KIA 2024 Book 2.17.5 41 10/24/24 01:21

Pemenuhan Gizi dan Perawatan Anak 2 - 5 Tahun

Penuhi Gizi Balita dengan Makanan Keluarga yang Bervariasi

Makanan pokok, lauk-pauk, minyak, sayur dan buah.






- Membiasakan anak makan 3 kali sehari (pagi, siang, dan malam) bersama keluarga
- Penuhi gizi anak dengan makanan kaya protein seperti ikan, telur, tempe, susu, dan tahu.
- Penuhi gizi anak dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan.
- Batasi anak mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak.
- Pastikan anak minum air putih sesuai kebutuhan.
- Biasakan bermain bersama anak dan melakukan aktivitas fisik setiap hari.

Kebutuhan Cairan Anak



- Umur 2 - 3 tahun sekitar 1.300 mL/hari atau +/- 5 gelas belimbing.
- Umur di atas 3 tahun kebutuhan cairan 1.700 mL/hari atau +/- 7 gelas belimbing.

Biasakan Mencuci Tangan



- Biasakan cuci tangan dan kaki anak dengan air bersih dan sabun setiap habis bermain.
- Gunting kuku tangan dan kaki secara teratur dan jaga kebersihan.

Perawatan Gigi Anak Anda

- Mulai ajari anak menyikat gigi di depan cermin, secara teratur selama 2 menit dampingi anak menggosok gigi sampai anak usia 8 tahun.
- Untuk anak usia 2-6 tahun pasta giginya
- seukuran 1 biji kacang polong.
- Untuk mengurangi risiko gigi berlubang pada anak:
  - Jangan biasakan anak minum susu dengan botol sambil tiduran.
  - Jangan membiarkan anak melakukan kebiasaan menghisap ibu jari atau dot (mengempeng).
  - Hindari anak dari makan makanan manis yang bersifat lengket di antara waktu makan.
  - Teratur menyikat gigi sebelum tidur.
- Jangan membiasakan anak mengemut makanan.
- Hanya memilih konten program yang berkualitas untuk anak, batasi tidak lebih dari 1 jam per hari.
- Hendaknya dimainkan bersama orang tua sehingga anak dapat mengetahui cara terbaik untuk menggunakannya.
- Hindarkan anak menggunakan gawai sendirian tanpa pendampingan orang tua.




Perawatan Anak Umur 2 - 3 Tahun (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (Februari atau Agustus).
- Obat cacing.

Perawatan Gigi

Lanjutkan perawatan gigi dengan mengingatkan anak menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur.

Pantau Tumbuh Kembang Anak Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 2 - 3 tahun dengan:

- Sebutkan nama benda, sifat, guna benda.
- Bacakan cerita, tanya jawab.
- Anak diminta bercerita pengalaman menonton TV didampingi maksimal 1 jam, menyanyi.
- Cuci tangan, cebok, berpakaian, rapikan mainan.
- Makan dengan sendok garpu.
- Menyusun balok, memasang puzzle, menggambar, menempel.
- Mengelompokkan benda sejenis.
- Mencocokkan gambar dan benda.
- Menghitung.
- Melempar, menangkap.
- Berlari, melompat, memanjat, merayap.

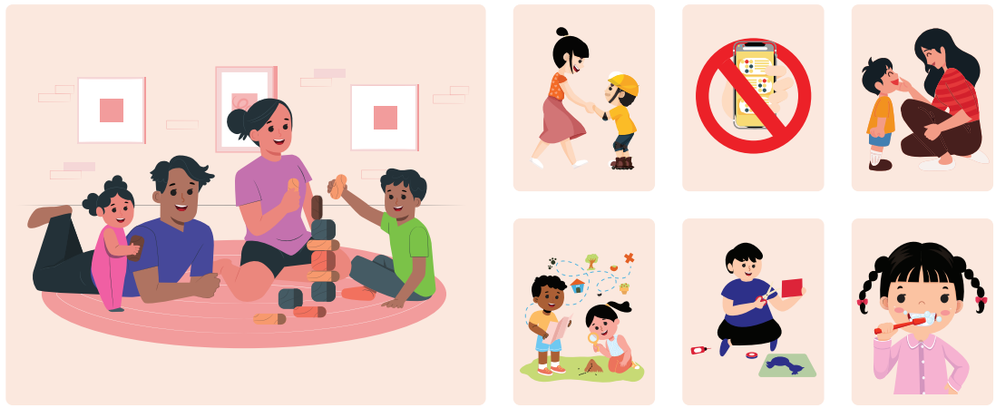
Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa jalan naik tangga sendiri?		
2	Anak bisa bermain dan menendang bola kecil?		
3	Anak bisa mencoret-coret pensil pada kertas?		
4	Anak bisa bicara dengan baik, menggunakan 2 kata?		
5	Anak bisa menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta?		
6	Anak bisa melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama 2 benda atau lebih?		
7	Anak bisa membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?		
8	Anak bisa makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?		
9	Anak bisa melepas pakaiannya sendiri?		

KIA 2024 Book 2.17.5 42 10/24/24 01:21

2 - 6 TAHUN

Pola Asuh Anak Umur 3 - 6 Tahun



- Harus ada kerjasama ayah dan ibu serta anggota keluarga dalam membantu anak menjalani tahap usia dini. Pada tahap ini terjadi proses mencontoh peran yaitu anak laki-laki mencontoh peran ayah sedangkan anak perempuan mencontoh peran ibu. Ajari anak konsep perbedaan laki-laki dan perempuan.
- Mengajari anak untuk menjaga bagian pribadinya (alat kelamin, paha, dada, pantat dan kaki) untuk menghindari pelecehan.
- Orang tua membantu anak mengucapkan kata-kata dengan benar.
- Memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun non materi.
- Beri kepercayaan anak untuk melakukan hal-hal tertentu secara mandiri sesuai kemampuan anak.
- Memberi kesempatan pada anak untuk mengurusi diri-sendiri dengan pengawasan.
- Ketika anak ketakutan, dekaplah dia agar merasa aman, bicarakan ketakutannya, buat anak menjadi nyaman dan merasa dimengerti.
- Anak 3-5 tahun perlu tidur 10-13 jam sehari (termasuk tidur siang).

- Penggunaan gawai pada anak berusia lebih dari 24 bulan:
  - Batasi penggunaan gawai tidak lebih dari 1 jam per hari.
  - Hanya memilih konten program yang berkualitas untuk anak.
  - Hendaknya dimainkan bersama orang tua (didampingi) untuk meningkatkan proses belajar anak, memperbanyak interaksi, dan mengatur pembatasan waktu penggunaan gawai.
- Jangan mengunakan gawai selama proses makan, dan pada 1 jam sebelum waktunya tidur.
- Matikan semua TV dan perangkat media bila sedang tidak digunakan.
- Jangan menggunakan gawai dengan tujuan untuk menenangkan perilaku anak.
- Berupaya agar kamar tidur, waktu saat makan, dan waktu bermain dengan anak, semuanya terbebas dari penggunaan gawai.
- Mempunyai berbagai alternatif aktivitas lain dalam rangka membatasi waktu penggunaan gawai, belajar memecahkan masalah, dan untuk menenangkan perilaku anak.

Bawa anak ke Posyandu/Fasilitas Kesehatan setiap bulan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan (sesuai jadwal), pelayanan imunisasi, vitamin A dan obat cacing.

Perawatan Anak Umur 3 - 4 Tahun (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (Februari atau Agustus).
- Obat cacing.

Perawatan Gigi

Lanjutkan perawatan gigi dengan mengingatkan anak menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur.

Pantau Tumbuh Kembang Anak Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 3 - 4 tahun dengan:

- Menyebutkan nama benda, sifat, guna benda.
- Bacakan cerita, tanya jawab.
- Anak diminta bercerita pengalaman.
- Menonton TV didampingi, menyanyi.
- Cuci tangan, cebok, berpakaian, rapikan mainan.
- Makan dengan sendok garpu.
- Menyusun balok atau puzzle, menggambar, menempel.
- Mengelompokkan benda sejenis.
- Mencocokkan gambar dan benda.
- Menghitung.
- Melempar, menangkap.
- Berlari, melompat, memanjat, merayap.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri 1 kaki 2 detik?		
2	Anak bisa melompat kedua kaki diangkat?		
3	Anak bisa mengayuh sepeda roda tiga?		
4	Anak bisa menggambar garis lurus?		
5	Anak bisa menumpuk 8 buah kubus?		
6	Anak bisa mengenal 2-4 warna?		
7	Anak bisa menyebut nama, umur, tempat?		
8	Anak bisa mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan?		
9	Anak bisa mendengarkan cerita?		
10	Anak bisa mencuci dan mengeringkan tangan sendiri?		
11	Anak bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan?		
12	Anak bisa mengenakan sepatu sendiri?		
13	Anak bisa mengenakan celana panjang, kemeja, baju?		

KIA 2024 Book 2.17.5 43 10/24/24 01:21

Perawatan Anak Umur 4 - 5 Tahun (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan
Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (Februari atau Agustus).
- Obat cacing.

Perawatan Gigi
Lanjutkan perawatan gigi dengan mengingatkan anak menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur.

Pantau Tumbuh Kembang Anak Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 4 - 5 tahun dengan:
- Bermain peran, anak diminta bercerita pengalaman.
- Menggambar orang, mengenal huruf.
- Main bola, lompat tali.
- Latih untuk dapat mengikuti aturan permainan.
- Kenalkan nama-nama hari.
- Menyebut angka berurutan.
- Mengajak anak sikat gigi bersama dan melatih sikat gigi sendiri.
- Melatih memakai pakaian sendiri.
- Menguatkan kepercayaan diri anak.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri 1 kaki 6 detik		
2	Anak bisa melompat-lompat 1 kaki		
3	Anak bisa menari		
4	Anak bisa menggambar tanda silang		
5	Anak bisa menggambar lingkaran		
6	Anak bisa menggambar orang dengan 3 bagian tubuh		
7	Anak bisa mengancing baju atau pakaian boneka		
8	Anak bisa menyebut nama lengkap tanpa dibantu		
9	Anak bisa senang menyebut kata-kata baru		
10	Anak bisa senang bertanya tentang sesuatu		
11	Anak bisa menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar		
12	Anak bisa bicara yang mudah dimengerti		
13	Anak bisa bisa membandingkan/membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya		
14	Anak bisa menyebut angka, menghitung jari		

Perawatan Anak Umur 5 - 6 Tahun (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan
Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Obat cacing.

Perawatan Gigi
Lanjutkan perawatan gigi anak anda dengan:
- Gigi susu sudah tumbuh semua: 20 buah, mulai tumbuh 2 gigi geraham tetap, rahang bawah pertama kiri dan kanan.
- Periksakan gigi anak secara rutin setiap 3-6 bulan sekali ke dokter gigi atau perawat gigi di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pantau Tumbuh Kembang Anak Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 5 - 6 tahun dengan:
- Mengenal nama, fungsi benda-benda.
- Bacakan buku, tanya jawab, bercerita.
- Menonton TV didampingi maksimal 1 jam, menyanyi.
- Cuci tangan, cebok, berpakaian, rapikan mainan.
- Melempar, menangkap, berlari, melompat.
- Makan dengan sendok garpu, masak-masakan.
- Menggunting, menempel, menjahit.
- Menyusun balok, memasang puzzle, menggambar, mewarna, menulis nama.
- Mengingat, menghafal, mengerti aturan dan urutan.
- Membandingkan besar kecil, banyak sedikit.
- Menghitung, konsep satu dan setengah.
- Mengenal angka, huruf, simbol, jam, hari dan tanggal.
- Memanjat, merayap, sepeda roda 3, ayunan.
- Bermain berjualan, bertukang, dan mengukur.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berjalan lurus?		
2	Anak bisa berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik?		
3	Anak bisa menggambar dengan 6 bagian, menggambar orang lengkap?		
4	Anak bisa menangkap bola kecil dengan kedua tangan?		
5	Anak bisa menggambar segi empat?		
6	Anak bisa mengerti arti lawan kata?		
7	Anak bisa mengerti pembicaraan yang menggunakan 7 kata atau lebih?		
8	Anak bisa menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya?		
9	Anak bisa mengenal angka, bisa menghitung angka 5 -10?		
10	Anak bisa mengenal warna-warni?		
11	Anak bisa mengungkapkan simpati?		
12	Anak bisa mengikuti aturan permainan?		
13	Anak bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu?		

KIA 2024 Book 2.17.5 44 10/24/24 01:21

Menjaga Kesehatan Mental Orang Tua dalam Pengasuhan Anak



Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk lingkungan yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang sehat. Untuk itu, orang tua harus memiliki kemampuan mengelola kesehatan fisik dan mentalnya.

Orang tua yang sehat mental mampu mengatasi stres, memberi aturan yang jelas pada anak, paham kebutuhan anak, serta mau memperbaiki hubungan kembali setelah melepas emosi berlebihan. Anak yang dibesarkan oleh orang tua yang sehat mental akan lebih mudah untuk fokus belajar dan berteman.

Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua:

1. **Bekerja Sama dalam Pengasuhan Positif**
   Ayah dan ibu bekerja sama dalam menerapkan pengasuhan yang tegas dan penuh kasih sayang.

   YANG HARUS DILAKUKAN
   - Orang tua menyepakati aturan yang diterapkan pada anak.
   - Tidak saling menyalahkan saat menghadapi masalah dalam pengasuhan.

2. **Mengenali dan Mengelola Emosi dalam Pengasuhan**
   Mengasuh anak tentunya memunculkan banyak tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi emosi orang tua. Oleh karena itu, orang tua perlu mengelola emosinya dengan baik.

   YANG HARUS DILAKUKAN
   - Kenali diri sendiri. Apa yang membuat saya marah? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat diri merasa lebih baik?
   - Atur harapan dan prioritas. Misalnya, anak sedang sakit dan orang tua kelelahan. Jangan memaksakan diri untuk melakukan semua hal,, seperti mencuci atau menyetrika baju.
   - Bekerja sama dengan pasangan untuk meringankan beban.
   - Tetap melakukan hobi untuk menjaga rasa bahagia.

3. **Memahami dan Mengelola Stres Pengasuhan**
   Ketika orang tua merasa tidak mampu menghadapi tantangan saat mengasuh anak, seperti anak sulit makan, berat badan anak kurang, atau perilaku anak tidak sesuai, maka akan timbul stres pengasuhan.

   YANG HARUS DILAKUKAN
   - Keloia stres dengan baik, misalnya dengan melakukan relaksasi.
   - Cari bantuan tenaga kesehatan di Puskesmas, jika stres sudah mengganggu kehidupan sehari-hari.

Orang tua yang terjaga kesehatan mentalnya mampu membentuk keluarga yang tangguh dan anak yang sehat.

Pindai kode QR untuk membaca buku Pengasuhan Positif.

Informasi Umum

Menjaga Kebersihan, Keselamatan Anak, dan Lingkungan



Hal-hal yang harus dilakukan untuk anak di semua rentang usia

- Jaga kebersihan diri dan lingkungan anak dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan pakai sabun, menjauhkan anak dari paparan asap rokok dan lain-lain.
- Lakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut anak (lihat halaman 87).
- Berikan perlindungan dan keamanan bagi anak dari bahaya, seperti kecelakaan, kekerasan, dan lain-lain..
- Orang tua/keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita setiap bulan .

KIA 2024 Book 2.17.5 45 10/24/24 01:21

Cuci Tangan Pakai Sabun

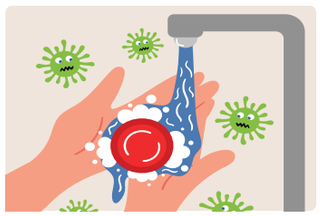
Kapan Saja Harus Mencuci Tangan

1. Setelah buang air
2. Sebelum memegang dan menyusui bayi
3. Setelah menceboki bayi atau anak
4. Sebelum makan dan menyuapi anak
5. Sebelum memegang makanan dan setelah makan
6. Setelah bersin/batuk
7. Setiap kali tangan kita kotor: mengetik, memegang uang, hewan/binatang, berkebun.



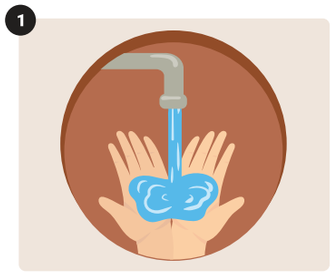
Pentingnya Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun

1. Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, yang bisa menimbulkan penyakit
2. Tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata namun tetap mengandung kuman
3. Sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman tertinggal di tangan.

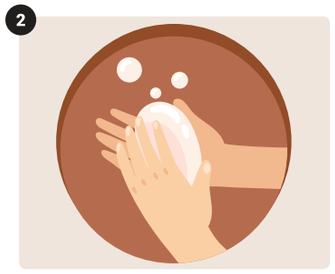


Cara Cuci Tangan Yang Benar

Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.



1 Basahi seluruh tangan dengan air bersih. mengalir.



2 Gosok sabun secara merata.



3 Ke telapak punggung, dan sela-sela jari tangan.



4 Telapak kanan di atas tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan.



5 Bersihkan bagian bawah kuku.



6 Bilas tangan dengan air bersih mengalir.



7 Keringkan tangan dengan handuk/tisue atau keringkan dengan diangin-anginkan.

Perawatan Gigi Anak



Faktor Risiko Gigi Berlubang

- Meminum susu botol saat tidur malam
- Mengemil makanan manis di antara waktu makan
- Tidak menyikat gigi sebelum tidur
- Mengemut makanan

Cara Membersihkan Gigi Anak

Anak Usia 0 - 4 Bulan

1. Gendong atau pangku anak dengan satu tangan.
2. Bersihkan gusi anak secara perlahan dengan kain atau lap basah yang dilingkarkan pada jari telunjuk ibu.

Anak Usia 6 - 12 Bulan

1. Bersihkan gusi anak setelah diberi makan menggunakan kain atau lap basah.
2. Bila gigi susu mulai muncul, bersihkan giginya dengan sikat gigi anak berbulu halus tanpa pasta gigi atau dengan pasta gigi selapis tipis pada permukaan bulu sikat.

Perawatan Anak Sakit

Setiap orang tua pasti khawatir jika anaknya jatuh sakit. Namun, Ibu harus tetap tenang dan memastikan kebutuhan gizi si kecil tetap tercukupi selama sakit.

Saat anak sakit, daya tahan tubuhnya akan melemah, sehingga ia membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta memulihkan energinya. Oleh karena itu, yang harus Ibu lakukan saat merawat anak yang sedang sakit adalah

- Memberi asupan gizi lebih banyak
  Caranya bisa dengan menambah porsi ASI atau makanan minuman yang diberikan, atau menambah variasi makanan untuk menambah asupan gizinya.
- Memberi asupan gizi lebih sering
  Caranya dengan memberi makan lebih sering dari biasanya. Misalnya, jika anak biasa makan 3-4 kali dalam sehari, tambahkan 1-2 kali lagi, namun dengan porsi yang tidak membuat anak terlalu kenyang.

KIA 2024 Book 2.17.5 46 10/24/24 01:21

INFORMASI UMUM

Perawatan Anak Sakit

Demam



- Jika masih menyusu, berikan ASI lebih sering.
- Beri minum lebih sering dan lebih banyak.
- Jangan diselimuti atau diberi baju tebal.
- Kompres dengan air biasa atau air hangat.
- Jangan kompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil.
- Jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dosis.
- Untuk daerah endemis malaria, balita harus tidur di dalam kelambu anti nyamuk (mengandung insektisida).

Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Demam disertai kejang.
- Setelah diberi penurun panas, demam tidak turun dalam 2 hari,
- Demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau buang air besar berwarna hitam.

Batuk



- Berikan ASI lebih sering.
- Beri minum air matang lebih banyak.
- Jika umurnya diatas 1 tahun, beri kecap manis atau madu dicampur air jeruk nipis sebagai pelega tenggorokan.
- Jauhkan dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, polusi kendaraan bermotor dan debu.

Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Batuk tidak sembuh dalam 2 hari.
- Anak sesak napas.
- Demam.

Diare/Mencret



- Jika anak masih menyusu, terus berikan ASI sesering mungkin.
- Berikan segera 1/2 -1 gelas cairan oralit setiap anak buang air besar, jika tidak ada oralit, berikan air matang, kuah sayur bening, dan air tajin.
- Pemberian zinc setiap hari selama 10 hari berturut-turut:
  - untuk anak usia <6 bulan 1 kali 1/2 tablet.
  - untuk anak usia 6 bulan - 5 tahun 1 kali 1 tablet.
- Beri MP-ASI atau makan seperti biasa.
- Jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan.

Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Timbul demam.
- Ada darah dalam tinja.
- Diare makin parah.
- Muntah terus menerus.
- Anak terlihat sangat haus.
- Anak tidak mau makan dan minum.
- Diare berulang-ulang.

Luka dan Koreng



- Luka: Cuci bersih luka dengan air bersih mengalir.
- Koreng: Periksakan ke Puskesmas

Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Luka bernanah atau berbau.

Anak Dengan Disabilitas

Anak dengan disabilitas rentan terhadap masalah kesehatan karena lebih berisiko mendapat kekerasan baik dari keluarga atau lingkungan karena Anak dengan Disabilitas mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi, ketidakmampuan memelihara kebersihan perorangan dan cenderung berperilaku berisiko yang tidak sesuai norma masyarakat.



Orang tua dan anggota keluarga membantu Anak dengan Disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari:

1. Penguatan mental untuk bisa menerima kondisi anak dengan segala kekurangannya.
2. Melindungi dan memberi rasa aman pada anak dengan memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi secara terbaik.
3. Ajari anak dengan sabar melatih kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
4. Menyediakan makanan bergizi seimbang dan memeriksakan kesehatan anak secara teratur serta memantau tumbuh kembang anak.
5. Anak dengan disabilitas perlu kontrol teratur untuk terapi, pemantauan status gizi, kemajuan perkembangan, serta melengkapi status imunisasi di Puskesmas terdekat. Anak dengan disabilitas rentan terhadap masalah kesehatan karena lebih berisiko mendapat kekerasan dari orang tua/lingkungannya akibat dari kelainan/ kecacatannya, mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi, ketidakmampuan anak dalam memelihara kebersihan perorangan, cenderung berperilaku berisiko yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.
6. Anak dengan gangguan kemampuan berbicara dan berbahasa, pahami anak akan kesulitan dalam mengekspresikan secara lisan. Melatih anak melafalkan huruf, vokal dan konsonan, suku kata, kata, dan kalimat, melatih anak memperhatikan dan mendengar pembicaraan.

Komunitas orang tua, organisasi masyarakat untuk anak dengan disabilitas:

1. Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK).
2. Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome (POTADS).
3. Ikatan Sindrome Down Indonesia (ISDI).
4. Komunitas Peduli Tuna Daksa (KOPETUNDA).
5. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI).
6. Himpunan Wanita Disabilitas I ndonesia (HWDI).
7. Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN).
8. Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI).
9. Yayasan Autis Indonesia (YAI).
10. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).
11. Yayasan Sayap Ibu.
12. Bagi keluarga yang jauh dari komunitas tersebut di atas, dapat melibatkan diri dalam kegiatan Posyandu, PAUD, PKK, RBM. Polindes/Poskesdes, dan Puskesmas terdekat.

KIA 2024 Book 2.17.5 47 10/24/24 01:21

Perlindungan Anak

Bagaimana melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual?



Lindungi Anak dari Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran. Contoh bentuk kekerasan:

- Mencubit, memukul (kekerasan fisik).
- Mengejek, mengancam (kekerasan psikis).
- Melakukan perbuatan cabul terhadap anak, mempertontonkan aktivitas seksual terhadap anak (kekerasan seksual).
- Tidak memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan (penelantaran).

Awas! Banyak pelaku kekerasan fisik dan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal anak.

Bangun komunikasi dengan anak

- Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian
- Orang Tua belajar melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak
- Hargai pendapat dan seleranya walau mungkin orang tua tidak setuju
- Jika anak cerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanya anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut

Ajarkan anak: Tidak boleh ada orang yang menyentuh bagian pribadinya, seperti kelamin, paha, dada, pantat dan kaki.

Kenali dan penuhi hak anak Anda

- Kelola stres Anda dan anggota keluarga lainnya
- Ketahui selalu keberadaan anak Anda
- Pastikan pengasuh anak Anda dapat dipercaya

Perhatikan adanya tanda-tanda kekerasan pada anak

- Memar dan luka yang tidak bisa dijelaskan
- Gangguan makan dan tidur
- Perubahan perilaku
- Adanya infeksi menular seksual

Kesehatan Lingkungan (Diisi oleh keluarga)

Baca dan pahami hal-hal di bawah ini. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada kader.

Sarana Sanitasi (pilih salah satu)

1. Di mana ibu dan keluarga buang air besar?
   - ☐ Sembarangan (di kebun, sungai dll)
   - ☐ Jamban milik sendiri
2. Bila jamban milik sendiri, bagian bawahnya/ bak penampung tinja berupa apa?
   - ☐ Tangki septik disedot setiap 3-5 tahun terakhir atau disalurkan ke sistem pengolahan
   - ☐ Cubluk/lubang tanah
   - ☐ Dibuang langsung ke drainase/kolam/ sawah/sungai/danau/laut dan pantai/tanah lapang/kebun
3. Bagaimana bentuk kloset jambannya?
   - ☐ Kloset leher angsa/lainnya yang mencegah binatang pembawa penyakit masuk

Cuci Tangan Pakai Sabun

1. Seperti apa jenis sarana cuci tangan dirumah ibu?
   - ☐ Memiliki sarana/tempat
   - ☐ Memiliki air mengalir
   - ☐ Memiliki sabun
2. Apakah ibu melakukan cuci tangan pakai sabun (lihat halaman 86)?
3. Apakah ibu mengetahui waktu-waktu kritis cuci tangan pakai sabun?
   - ☐ Sebelum makan
   - ☐ Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan
   - ☐ Sebelum menyusui anak, sebelum memberi makan bayi/balita
   - ☐ Setelah buang air besar/kecil

Pengelolaan Makanan dan Air Minum

1. Apa sumber air minum di rumah ibu?
   - ☐ Pipa
   - ☐ Kran umum
   - ☐ Sumur bor/pompa/sumur gali yang terlindungi
   - ☐ Mata air terlindungi
   - ☐ Sungai/mata air tidak terlindungi
   - ☐ Danau/kolam/sumur gali tidak terlindungi
   - ☐ Air hujan
   - ☐ Waduk
   - ☐ Kolam
   - ☐ Irigasi
2. Bagaimana ibu mengelola air minum di rumah tangga?
   - ☐ Melalui proses pengolahan (misal: merebus)
   - ☐ Jika air keruh dilakukan pengolahan, seperti: pengendapan atau penyaringan
   - ☐ Menyimpan air minum di dalam wadah yang tertutup rapat, kuat dan diambil dengan cara yang aman (tidak tersentuh tangan atau mulut)
3. Bagaimana ibu mengelola makanan di dalam keluarga?
   - ☐ Makanan tertutup baik dengan penutup yang bersih
   - ☐ Makanan tidak berdekatan dengan bahan berbahaya dan beracun (deterjen, pestisida, cairan obat nyamuk, dan sejenisnya)
   - ☐ Mengelola makanan dengan baik dan benar yaitu menjaga kebersihan, memisah makanan mentah dan matang, memasak sampai matang, tidak membiarkan makanan matang di luar lebih dari 4 jam serta menggunakan air yang aman.

Pengelolaan Sampah

Bagaimana ibu mengelola sampah?

- ☐ Tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah
- ☐ Ada tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan
- ☐ Telah melakukan pemilahan sampah
- ☐ Tidak dibakar
- ☐ Tidak dibuang ke sungai/kebun/saluran drainase/tempat terbuka

Pengelolaan Limbah Cair (air bekas cuci baju, piring, mandi):

Bagaimana ibu mengelola limbah cair di rumah?

- ☐ Tidak terlihat genangan air di sekitar rumah
- ☐ Ada saluran pembuangan limbah cair rumah tangga (non kakus) yang kedap dan tertutup
- ☐ Terhubung dengan sumur resapan dan atau sistem pengolahan limbah

KIA 2024 Book 2.17.5 48 10/24/24 01:21

INFORMASI UMUM

Keselamatan Lingkungan (Diisi oleh Keluarga)

Baca dan pahami hal-hal di bawah ini. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada kader.

Hindarkan anak dari risiko jatuh

- ☐ Televisi, meja, lemari, dan rak yang tidak cukup kuat dipanjat oleh bayi harus diikat atau menempel di dinding. Beri bantalan pada tepi mebel/perabot yang sudutnya tajam.
- ☐ Baby walker tidak disarankan karena menghambat anak dalam melakukan langkah dan dapat menyebabkan bayi terjatuh.
- ☐ Jendela paling sedikit 1 meter dari lantai untuk mencegah bayi memanjat.
- ☐ Sering-seringlah memeriksa gerbang pagar rumah untuk mencegah bayi memanjat.
- ☐ Jangan tinggalkan bayi sendirian di tempat-tempat tinggi.
- ☐ Tangga dan balkon dipasang pagar dan jarak antar pagarnya tidak lebih dari 9 cm untuk mencegah kepala atau bagian tubuh bayi melewatinya.
- ☐ Memasang pengaman di sekitar tempat tidur anak untuk mencegah anak jatuh dari tempat tidur.

Hindarkan Anak dari Luka Bakar dan Bahaya Listrik

- ☐ Jauhkan anak dari kabel listrik dan panci panas.
- ☐ Soket listrik harus dipasang jauh dari jangkauan anak-anak atau dengan perangkat penutup.
- ☐ Jangan memegang barang yang panas ketika memegang atau memangku bayi.

Mencegah Bayi Kekurangan Napas

- ☐ Jangan memberikan makanan anak yang keras dan sulit dikunyah.
- ☐ Jangan biarkan anak bermain dengan benda benda yang berisiko anak terjerat/ tercekik, tidak bisa bernafas (tali panjang, kantong plastik, mainan kecil, dan lain-lain).
- ☐ Hindari menidurkan bayi dalam posisi telungkup tanpa pengawasan.

Hindarkan Anak dari Bahaya Tenggelam

- ☐ Jangan biarkan anak sendiri di bak mandi atau ember.
- ☐ Beri pembatas yang aman agar anak tidak leluasa menjangkau sumber air sendiri. Jangan biarkan anak bermain di tepi kolam renang tanpa pengawasan.
- ☐ Anak usia 1 tahun 6 bulan diajari tentang bahaya air.
- ☐ Anak usia 2 tahun harus diajari cara melayang ketika jatuh di air dan berenang jarak pendek.
- ☐ Anak usia 6 tahun harus bisa berenang dengan keterampilan bertahan di air.

Catatan Kader

Kesiap-siagaan Dalam Situasi Bencana



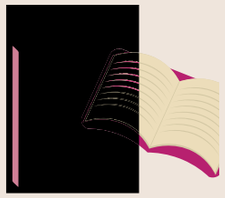
Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah yang rawan bencana, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan/ lahan longsor, banjir, tsunami, di samping bencana non alam seperti pandemi virus atau situasi konflik. Kelompok yang paling rentan terdampak bencana diantaranya adalah ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita. Kondisi pengungsian yang padat dan tidak memadai, dengan hygiene dan sanitasi yang buruk, berisiko tinggi menimbulkan berbagai penyakit, termasuk risiko terinfeksi penyakit menular dan peningkatan kasus gizi kurang. Disamping itu juga berisiko terhadap pelecehan, kekerasan, dan trauma. Selain risiko kesakitan, kecacatan dan kematian, anak dan balita juga memiliki risiko terpisah dari orang tua.

Reaksi bayi dan anak berumur 1-2 tahun sangat dipengaruhi oleh suasana kejiwaan orangtuanya dalam menghadapi bencana. Bila orang tua panik dan cemas, maka anak- anak tersebut akan gelisah, rewel dan mudah terkena penyakit. Anak usia prasekolah mudah merasa tidak berdaya dan terus mengingat trauma psikis yang dialami akibat bencana. Hal ini mengakibatkan gangguan tidur dan anak lebih banyak berdiam diri. Bimbingan untuk bermain dapat mengurangi masalah tersebut. Dalam situasi normal, ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita terutama yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana:

- Membuat rencana darurat keluarga.
  - Kenali ancaman bencana.
  - Nomor kontak penting (keluarga, fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit/ puskesmas/rumah bersalin/klinik, dan lain-lain).
  - Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik.
  - Identifikasi titik kumpul dan titik aman di dalam bangunan atau rumah.
  - Ketahui rute evakuasi.
  - Identifikasi anggota keluarga yang rentan (bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin nifas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas).
- Menyimak informasi dari radio/televisi media online/informasi resmi dari BPBD, BNPB. Apabila sudah terbentuk posko informasi lanjutan akan diberikan oleh posko setempat.
- Menyiapkan kit bencana.

KIA 2024 Book 2.17.5 49 10/24/24 01:21

Persiapan Kit Bencana



Buku KIA
Buku pedoman untuk ibu hamil/bersalin/ nifas dan pedoman bayi dan balita.



Obat-obatan
Obat sehari-hari dan obat-obatan rutin, vitamin, serta perlengkapan pendukungnya.



Kalung Tanda Pengenal
Tanda pengenal berisi informasi nama, nama orang tua, no. telepon orang tua, dan alamat.



Peralatan Elektronik
Handphone, powerbank, kabel charger, radio walkie-talkie, baterai.



Benda Khusus Bayi dan Balita
Pakaian, selimut, popok, topi, kaos kaki, dan mainan secukupnya.



Peralatan Bertahan Hidup
Pisau, gunting, peluit, pisau serba guna, senter, korek/ pemantik api.



Benda Khusus Ibu
Kain panjang, pakaian lengkap dan perlengkapan lain secukupnya.



Makanan dan Minuman
Makanan instan, air mineral, roti, dan makanan praktis untuk dibawa di dalam tas.



Pembersih Higienis
Tisu basah dan tisu kering, hand sanitizer, perlengkapan mandi.



Uang dan Dokumen Penting
Uang tunai, KTP/ Paspor, kartu ATM, dan dokumen penting lainnya.



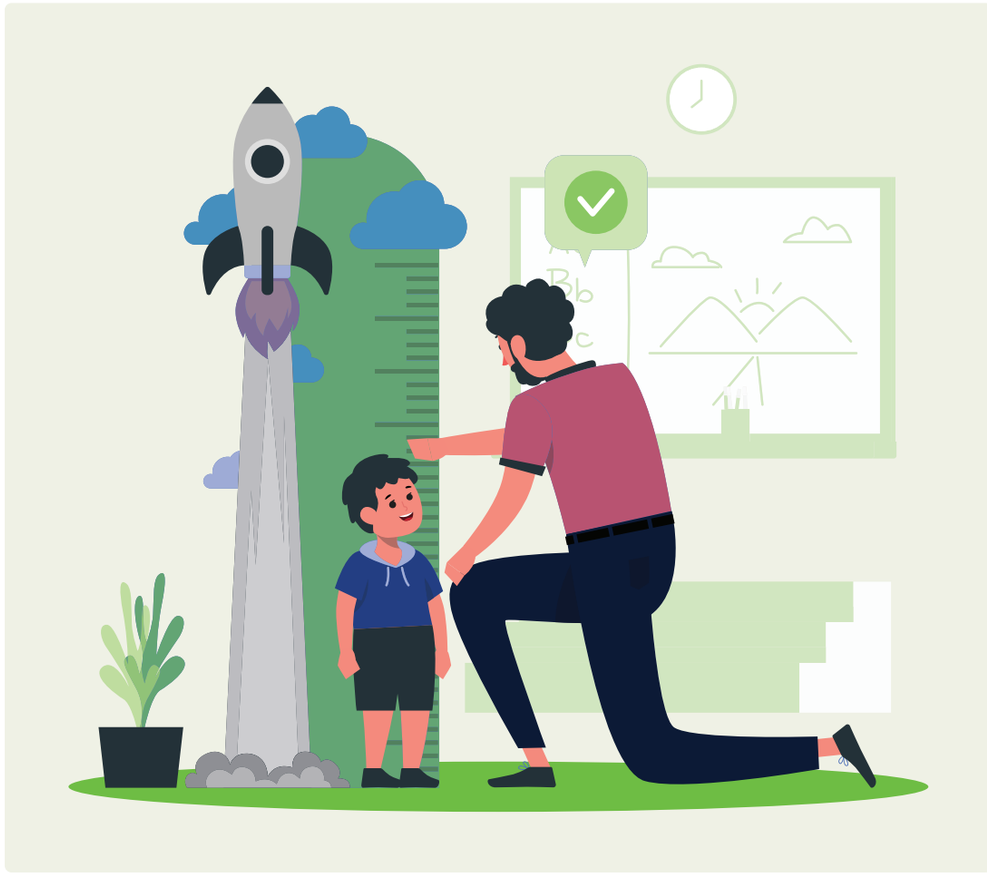
Perlengkapan Keselamatan
Jaket, sepatu, sarung tangan, masker, helm, jas hujan/ponco ringan.



Tas Ransel
Tas untuk membawa semua perlengkapan persiapan kit bencana.

Pengukuran & Pencatatan oleh Tenaga Kesehatan

Pemantauan Kesehatan Ibu dan Tumbuh Kembang Anak



Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di setiap tahap kehidupan penting dilakukan untuk memantau kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan, serta tumbuh kembang anak secara terbaik.

Pemantauan kesehatan ibu bertujuan untuk memastikan proses melahirkan yang sehat, sedangkan pemantauan tumbuh kembang anak untuk memastikan si kecil tumbuh sehat sesuai usianya dan mencegah stunting.

Tabel dan grafik yang ada di sini mencatat setiap pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh kader maupun tenaga kesehatan, disertai dengan edukasi tentang hal-hal yang dipantau di bagian depan. Pastikan semua pencatatan dilakukan dengan cermat demi mewujudkan ibu dan anak yang sehat.

KIA 2024 Book 2.17.5 50 10/24/24 01:21

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan.

HPHT/Trimester	I 12 Minggu Pertama	II 12 - 24 Minggu		III Di Atas 24 Minggu		
Kunjungan ke-	1	2	3	4	5	6
Tanggal dan Tempat						
Tanggal periksa						
Tempat periksa						
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan						
Tinggi Badan						
Lingkar Lengan Atas						
Tekanan Darah						
Tinggi Rahim						
Letak dan Denyut Jantung bayi						
Status dan Imunisasi Tetanus						
Konseling						
Skrining Dokter						
Tablet Tambah Darah						
Tes Lab Hemoglobin (Hb)						
Tes Golongan Darah						
Tes Lab Protein Urine						
Tes Lab Gula Darah						
USG						
Tripel Eliminasi (H/S/Hep B)						
Tata Laksana Kasus						

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan



Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi;

- ☐ **Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan**
  - Ukur tinggi badan Ibu untuk menentukan status gizi dan risiko proses melahirkan
  - Pantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan
- ☐ **Ukur tekanan darah**
  Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya Hipertensi atau tekanan darah | ≥140/90 mmHg.
- ☐ **Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)**
  Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya risiko kurang energi kronis jika LiLA <23,5 cm.
- ☐ **Ukur tinggi Fundus Uteri/tinggi rahim**
- ☐ **Pemeriksaan presentasi bayi dan denyut jantung bayi**
  Tujuannya untuk melihat kelainan letak bayi atau masalah lain
- ☐ **Beri tablet tambah darah (TTD) atau suplemen kesehatan multivitamin dan mineral untuk ibu hamil (MMS) setiap hari selama kehamilan**
  Periksa kandungan TTD dan MMS sedikitnya berisi 30 - 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat.
- ☐ **Skrining status imunisasi Tetanus dan pemberian imunisasi bila diperlukan**

Status	Interval Minimual Pemberian	Masa Perlindungan
T1	Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus	
T2	1 bulan setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	12 bulan setelah T3	10 tahun
T5	12 bulan setelah T4	Lebih dari 25 tahun

- ☐ **Skrining Kesehatan Jiwa**
- ☐ **Tata laksana/penanganan kasus**
  Apabila ditemukan masalah, segera ditangani atau dirujuk
- ☐ **Temu wicara/konseling**
  Dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan

Periksa Laboratorium:

- Pemeriksaan Kadan Hemoglobin
- Protein Urin
- Triple Eliminasi: HIV, Sifilis, Hepatitis B
- Pemeriksaan lain sesuai indikasi

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

KIA 2024 Book 2.17.5 51 10/24/24 01:21

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Diisi oleh Dokter

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Fasilitas Kesehatan .....

Kondisi Kesehatan Ibu

TB	cm	IMT			
BB	kg	Kurus	Normal	Gemuk	Obesitas
LiLa	cm				

Status Imunisasi TD

TT	Selang Waktu	Perlindungan	✔
1		Awal	
2	1 bulan	3 tahun	
3	6 bulan	5 tahun	
4	12 bulan	10 tahun	
5	12 bulan	> 25 tahun	

Kesimpulan: Status imunisasi

Imunisasi lainnya: COVID-19/ .....

Pemeriksaan Khusus

Inspeksi/ Inspekulo	Porsio	Normal	Tidak normal
	Uretra	Normal	Tidak normal
	Vagina	Normal	Tidak normal
	Vulva	Normal	Tidak normal
	Fluksus	+ / - -	+ / - -
	Fluor	+ / - -	+ / - -

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan Sebelum Hamil

Aktivitas fisik kurang	Alkohol
Kosmetik yang mengandung zat berbahaya	Merokok
Obat Teratogenik	Pola makan berisiko
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Penyakit Keluarga

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kehamilan dan Proses Melahirkan

Termasuk keguguran, kembar, dan lahir mati.

No	Tahun	BB gram	Proses Melahirkan	Penolong Proses Melahirkan	Masalah
1					
2					
3					

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan < 12 minggu.

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum .....

Konjungtiva		Anemia	Tidak Anemia	
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit		Normal	Tidak normal	
Leher		Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal	
THT		Normal	Tidak normal	
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal	
	Paru	Normal	Tidak normal	
Perut		Normal	Tidak normal	
Tungkai		Normal	Tidak normal	

USG Trimester I

HPHT .....

Keteraturan haid: (Teratur/Tidak Teratur)*

Umur kehamilan berdasar HPHT (pada siklus haid teratur) ..... Minggu

HPL Berdasarkan HPHT (pada sikulus haid teratur) .....

Umur kehamilan berdasarkan USG ..... Minggu

HPL berdasarkan USG .....

Jumlah GS	Tunggal/kembar*
Diameter GS	..... cm, sesuai dengan umur kehamilan: ..... Minggu + ... hari
Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
CRL	..... cm, sesuai dengan umur kehamilan: ..... Minggu + ... hari
Letak Produk Kehamilan	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Pulsasi Jantung	Tampak/tidak tampak*
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir/Tnaggal Mulai Haid Terakhir, HPL: Hari Perkiraan Lahir/Tanggal Taksiran Persalingan, GS: Gestational Sac/ Kantung Kehamilan, CRL: Crown-Rump Length/Jarak Puncak Kepala Bokong.
- Bila embrio/fetus sudah tampak maka pengukuran yang dilakukan adalah CRL sementara GS tidak perlu dilakukan pengukuran.
- Pulsasi jantung adalah gerakan jantung yang tervisualisasi setelah CRL berukuran lebih dari 4.5 cm.
- Umur Kehamilan serta HPL USG yang dipakai adalah berdasarkan hasil pengukuran CRL (Trimester I).
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.

KIA 2024 Book 2.17.5 52 10/24/24 01:21

Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Pemeriksaan	Hasil		Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin		g/dL	
Golongan Darah & Rhesus			
Gula Darah Sewaktu		Mg/dL	
Tripel Eliminasi			
H	Reaktif	Non reaktif	
S	Reaktif	Non reaktif	
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif	

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Kesimpulan _____

Rekomendasi _____

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

KIA 2024 Book 2.17.5 53 10/24/24 01:21

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Skrining Preeklampsia

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Umur kehamilan < 20 minggu.

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Umur ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure > 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2x Pemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		
* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur ** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu MAP= (2XD) + S 3 / 3	Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya • ☐ 2 risiko sedang dan atau, • ☐ 1 risiko tinggi	

Beri tanda ✔ (centang)pilihan yang sesuai.

Kesimpulan _____

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa _____ Dokter Pemeriksa

(_____)

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 2

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

KIA 2024 Book 2.17.5 54 10/24/24 01:21

Pemeriksaan Dokter Trimester 3

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan 32 - 36 minggu.

Nama Dokter _____ Tanggal Periksa _____

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum _____

Konjungtiva		Anemia	Tidak Anemia	
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit		Normal	Tidak normal	
Leher		Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal	
THT		Normal	Tidak normal	
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal	
	Paru	Normal	Tidak normal	
Perut		Normal	Tidak normal	
Tungkai		Normal	Tidak normal	

USG Trimester III

USG Trimester III telah dilakukan: Ya/tidak*

- Bila ya, Umur Kehamilan saat ini berdasarkan USG Trimester I: ..... minggu.
- Bila tidak dan haid teratur, umur kehamilan saat ini berdasarkan HPHT: ..... minggu.

Umur Kehamilan berdasarkan biometri bayi USG Trimester III: ..... minggu.

Apakah terdapat selisih 3 minggu atau lebih diantara UK USG Trimester I/HPHT dengan UK USG Trimester III: Ya/tidak*

Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
Letak bayi	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Presentasi bayi	Kepala/Bokong/Letak Lintang*
Keadaan bayi	Hidup/meninggal*, DJJ: ..... X/m (normal/tidak normal)*
Lokasi Plasenta	Fundus/corpus/letak rendah/previa*
Jumlah Cairan Ketuban	SDP: ..... cm, cukup/kurang/berlebih*
Biometri bayi	BPD: ..... cm, sesuai: ..... minggu HC: ..... cm, sesuai: ..... minggu AC: ..... cm, sesuai: ..... minggu FL: ..... cm, sesuai: ..... minggu EFW/TBJ: ..... gram, sesuai: ..... minggu
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- DJJ: Denyut Jantung bayi, SDP: Ujuran, BPD: Biparietal Diameter/jarak tuluang parietal kepala, HC: Head Circumference/lingkar dada, AG: Abdominal Circumference/lingkar perut, PL: Femur Length/panjang tulang paha, EFW: Estimates Fetal Weight, TBU: Taksiran Berat bayi.
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 3 di halaman 19-20.

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium Tanggal ____ / ____ / 20____

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL	
Protein Urin	Mg/dL	
Urin Reduksi	Negatif/+ 1/+2/+3/+4	

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Rencana Konsultasi Lanjut

Gizi	Kebidanan	Anak	Penyakit Dalam	Neurologi	THT	Psikiatri	Lain-lain

Rencana Proses Melahirkan

Normal | Pervaginam berbantu | Sectio caesaria

Pilihan Rencana Kontrasepsi

AKDR	Pil	Suntik	Steril
MAL	Implan	Belum memilih	

Konseling

Kebutuhan konseling	Ya	Tidak

Penjelasan _____

Kesimpulan: Rekomendasi Tempat Proses Melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu).
Proses melahirkan dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

BPD Biparietal Diameter
HC Head Circumferential
MAL Metode Amenore Laktasi
AC Abdominal Circumferential
FL Femur Length
SDP Cairan Ketuban Single Deepest Pocket Cairan Ketuban

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 3 di halaman 19-20.

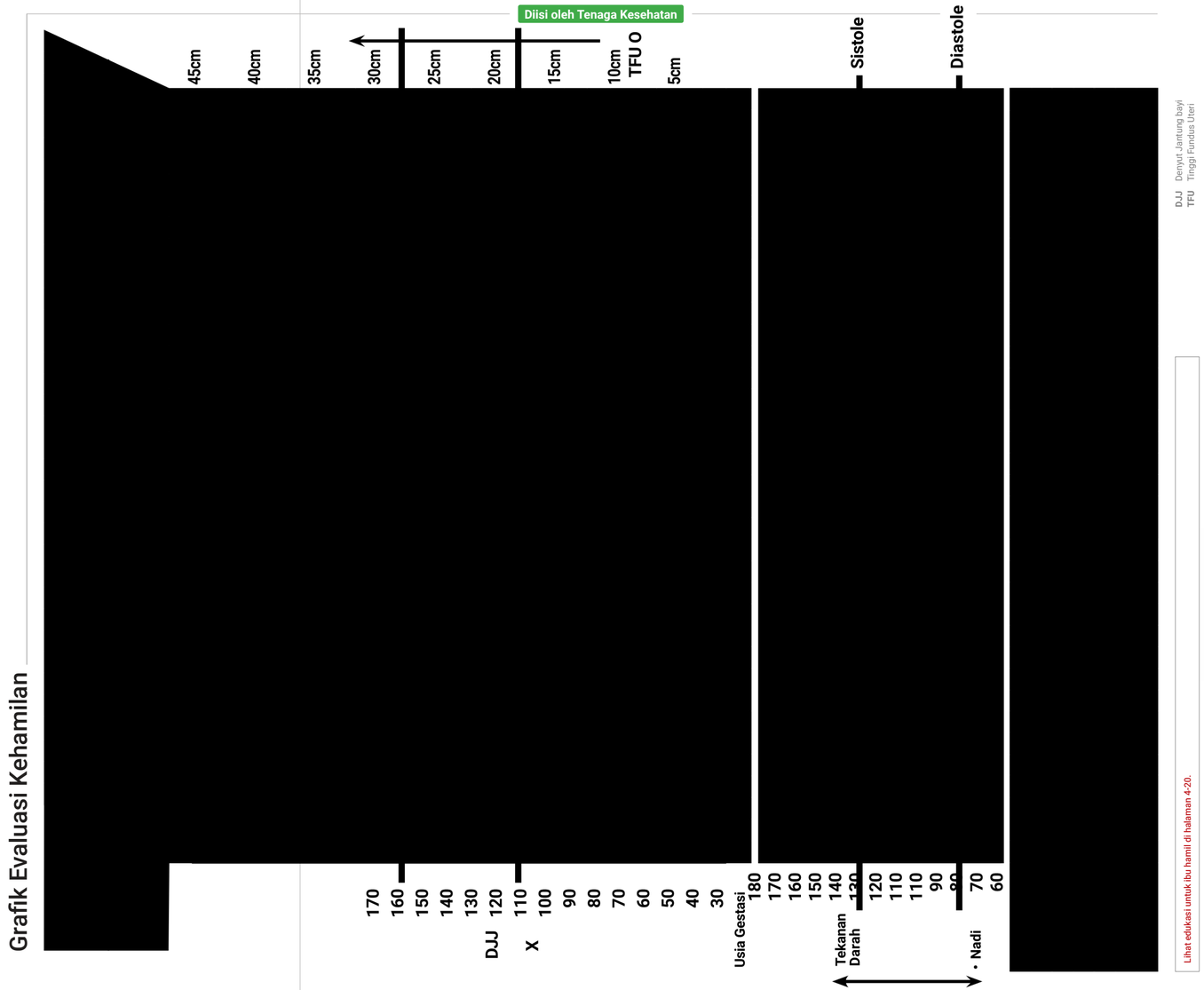
KIA 2024 Book 2.17.5 55 10/24/24 01:21

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 3

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

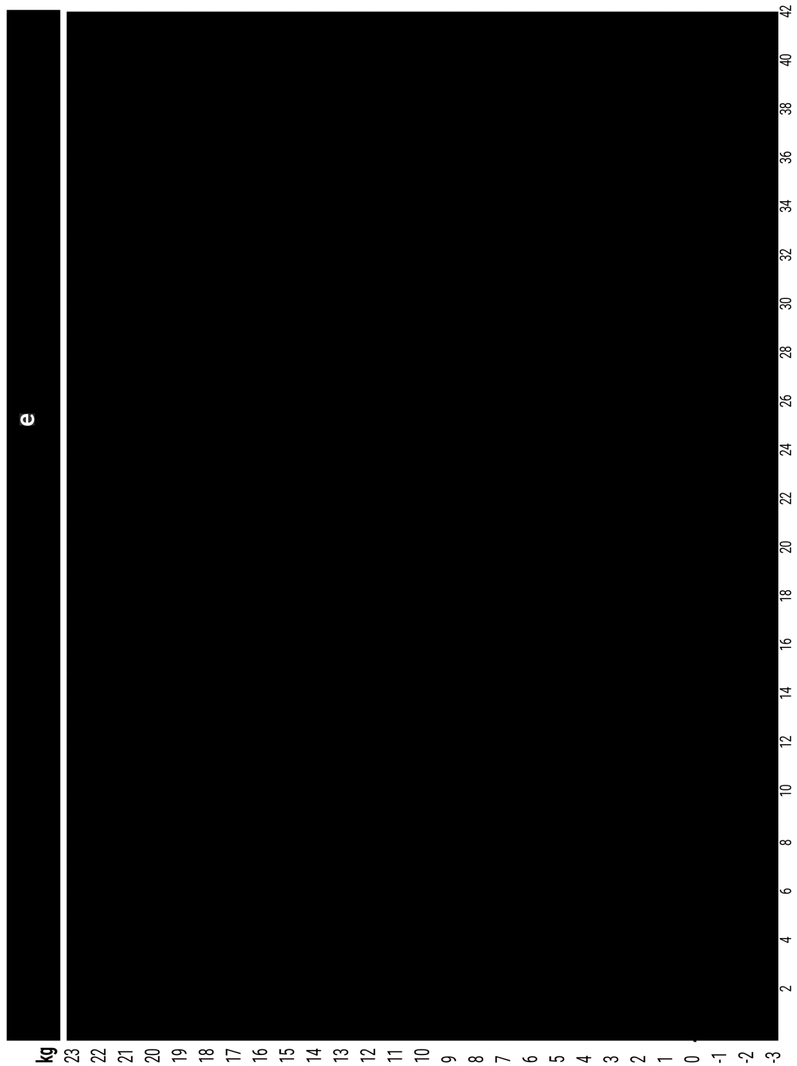


KIA 2024 Book 2.17.5 56

10/24/24 01:21

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Grafik Peningkatan Berat Badan



Tanda	BB Pra-kehamilan	IMT Pra-kehamilan	Rekomendasi Peningkatan Berat Badan
		<18,5	12,5 - 18 kg
		18,5 - 24,9	11,5 - 16 kg
		25 - 29,9	7 - 11,5 kg
		> 30	5 - 9 kg

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Penjelasan Hasil Grafik

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

KIA 2024 Book 2.17.5 57 10/24/24 01:21

Menyambut Proses Melahirkan

Agar aman dan selamat.

Diisi oleh Ibu

Saya _____

Alamat _____

Memberikan kepercayaan kepada nama-nama ini untuk membantu proses melahirkan saya agar aman dan selamat, yang diperkirakan pada, Bulan: _____ Tahun: _____

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Fasyankes proses melahirkan:

1. Bidan/dokter _____ Nama Fasyankes _____
2. Bidan/dokter _____ Nama Fasyankes _____

Untuk dana proses melahirkan akan menggunakan JKN/Jamkesda/asuransi swasta/biaya sendiri/lainnya _____

Untuk kendaraan/ambulan desa oleh:

1. _____ HP _____
2. _____ HP _____
3. _____ HP _____

Metode kontrasepsi setelah melahirkan yang dipilih:

Untuk sumbangan darah (golongan darah) _____ Rhesus _____ Dibantu oleh:

1. _____ HP _____
2. _____ HP _____
3. _____ HP _____
4. _____ HP _____

_____ Tanggal _____ 20 ____

Persetujuan Suami/ Orang Tua/Keluarga	Persetujuan Ibu Hamil	Bidan/Dokter
(_____)	(_____)	(_____)

Lihat edukasi untuk ibu melahirkan di halaman 21-25.

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Ringkasan Pelayanan Proses Melahirkan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Ibu Bersalin dan Ibu Nifas

Tanggal Melahirkan	_____ Pukul _____
Umur Kehamilan	_____ minggu
Penolong Proses Melahirkan	SpOG/Dokter umum/Bidan _____
Cara Melahirkan	Normal/Tindakan _____
Keadaan Ibu	Sehat/Sakit (Pendarahan/Demam/Kejang/Lokhia berbau/ lain-lain (_____)/Meninggal*
KB Pasca Melahirkan	_____
Keterangan Tambahan	_____

Bayi Saat Lahir

Anak ke	_____
Berat Lahir	_____ gram
Panjang Badan	_____ cm
Lingkar Kepala	_____ cm
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan/Tidak bisa ditentukan*

Kondisi Bayi Saat Lahir**

- ☐ Segera menangis
- ☐ Menangis beberapa saat
- ☐ Tidak menangis
- ☐ Seluruh tubuh kemerahan
- ☐ Anggota gerak kebiruan
- ☐ Seluruh tubuh biru
- ☐ Kelainan bawaan _____
- ☐ Meninggal

Asuhan Bayi Baru Lahir**

- ☐ Inisiasi menyusu dini (IMD) dalam 1 jam pertama kelahiran bayi
- ☐ Suntikan Vitamin K1
- ☐ Salep mata Antibiotika Profilaksis
- ☐ Imunisasi HB0

Keterangan Tambahan _____

Lihat edukasi untuk ibu melahirkan di halaman 21-25.

KIA 2024 Book 2.17.5 58 10/24/24 01:21

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

KETERANGAN LAHIR

No. _____

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;

Pada hari ini _____ Tanggal _____ Pukul _____

Telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan

Jenis Kelahiran Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya _____

Anak ke- _____ Usia gestasi _____

Berat Lahir _____ g Panjang Badan _____ cm Lingkar Kepala _____ cm

Di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Praktik Mandiri Bidan/di

_____

Alamat _____

Diberi Nama

_____

Dari Orang Tua;

Nama Ibu _____ Umur _____ tahun

NIK _____

Nama Ayah _____

NIK _____

Pekerjaan _____

Alamat _____ RW/RW _____

Kecamatan _____ Kab./Kota _____

_____ Tanggal _____ 20 _____

Saksi I	Saksi II	Penolong Kelahiran
(_____)	(_____)	(_____)

Mengesahkan

Fasilitas Kesehatan

_____

(_____)

GUNTING DI SINI

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

KETERANGAN LAHIR

No. _____

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;

Pada hari ini _____ Tanggal _____ Pukul _____

Telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan

Jenis Kelahiran Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya _____

Anak ke- _____ Usia gestasi _____

Berat Lahir _____ g Panjang Badan _____ cm Lingkar Kepala _____ cm

Di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Praktik Mandiri Bidan/di

_____

Alamat _____

Diberi Nama

_____

Dari Orang Tua;

Nama Ibu _____ Umur _____ tahun

NIK _____

Nama Ayah _____

NIK _____

Pekerjaan _____

Alamat _____ RW/RW _____

Kecamatan _____ Kab./Kota _____

_____ Tanggal _____ 20 _____

Saksi I Saksi II Penolong Kelahiran

(_____) (_____) (_____)

GUNTING DI SINI

Riwayat Proses Melahirkan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

G_____ P_____ A_____

Pada Hari _____ Tanggal _____ Pukul _____

Cara Melahirkan	☐ Spontan	☐ Sungsang	
Dengan Tindakan	☐ Ekstraksi Vakum	☐ Ekstraksi Forsep	☐ SC
Penolong Kelahiran	☐ Dokter Spesialis	☐ Dokter	☐ Bidan

Catatan Pemeriksaan	
Taksiran Melahirkan	
Fasyankes	
Rujukan	
Inisiasi Menyusu Dini	

Cap Kaki Bayi

Lihat edukasi untuk ibu melahirkan di halaman 21-25.

KIA 2024 Book 2.17.5 60 10/24/24 01:21

Ringkasan Pelayanan Nifas

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

6 Jam - 42 Hari Setelah Bersalin	KF 1 6 - 48 Jam	KF 2 3 - 7 Hari	KF 3 8 - 28 Hari	KF 4 29 - 42 Hari
Tanggal dan Tempat				
Tanggal Periksa				
Tempat Periksa				
Catatan Pemeriksaan				
Periksa Payudara (ASI)				
Periksa Pendarahan				
Periksa Jalan Lahir				
Vitamin A				
KB Pasca Melahirkan				
Skrining Kesehatan Jiwa				
Konseling				
Tata Laksana Kasus				

Kesimpulan Akhir Nifas

Keadaan Ibu*
- ☐ Sehat
- ☐ Sakit
- ☐ Meninggal

Keadaan Bayi*
- ☐ Sehat
- ☐ Sakit
- ☐ Kelainan Bawaan
- ☐ Meninggal

Masalah Nifas*
- ☐ Pendarahan
- ☐ Infeksi
- ☐ Hipertensi
- ☐ Lainnya, _____

Pastikan bayi mendapat pelayanan kesehatan neonatal (KN) dan catat hasil permeriksaan pada lembar anak.

Kesimpulan _____

* Beri tanda ✔ (centang) pada kolom yang sesuai

Lihat edukasi untuk ibu setelah melahirkan di halaman 26-33.

Perawatan Ibu Nifas

Perawatan ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan paling sedikit 4 kali kunjungan nifas.

- **Pertama** — 6 jam - 2 hari setelah melahirkan
- **Kedua** — 3 - 7 hari setelah melahirkan
- **Ketiga** — 8 - 28 hari setelah melahirkan
- **Keempat** — 29 - 42 hari setelah melahirkan

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

- Menanyakan kondisi ibu nifas secara umum
- Pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi
- Pemeriksaan lokhia dan perdarahan
- Pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi
- Pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri
- Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif
- Pemberian kapsul vitamin A (2 kapsul)
- Pelayanan kontrasepsi pasca proses melahirkan
- Skrining Kesehatan Jiwa
- Konseling
- Tatalaksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan masalah.
- Memberikan nasihat yaitu:

1. Makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Sesuai proporsional sesuai hal. 32
2. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari
3. Menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin.
4. Istirahat cukup, saat bayi tidur ibu istirahat
5. Melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit, frekuensi 3 - 5 kali dalam seminggu
6. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi caesar maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Latihan fisik dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan pasca melahirkan.
7. Cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan.
8. Perawatan bayi yang benar.
9. Jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama, karena akan membuat bayi stres.
10. Lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga
11. Untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah proses melahirkan.

Lihat edukasi untuk ibu setelah melahirkan di halaman 26-33.

KIA 2024 Book 2.17.5 61 10/24/24 01:21

Rujukan

Diisi oleh Dokter

Rujukan

Resume hasil pemeriksaan dan tatalaksana yang telah dilakukan di FKTP, diagnosis akhir alasan dan alasan dirujuk ke FKRTL:

Rujukan Balik

Tgl/Bln/Th

Diagnosis Akhir

Resume (hasil pemeriksaan dan tatalaksana di FKRTL):

Anjuran

Rekomendasi tempat proses melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu)

Rujukan

Resume hasil pemeriksaan dan tatalaksana yang telah dilakukan di FKTP, diagnosis akhir alasan dan alasan dirujuk ke FKRTL:

Rujukan Balik

Tgl/Bln/Th

Diagnosis Akhir

Resume (hasil pemeriksaan dan tatalaksana di FKRTL):

Anjuran

Rekomendasi tempat proses melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu)

Catatan Pelayanan Kesehatan Nifas

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

KIA 2024 Book 2.17.5 62 10/24/24 01:21

Catatan Pelayanan Kesehatan Anak

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Anak yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Bayi 0 - 28 Hari	0 - 6 Jam	6 - 48 Jam	3 - 7 Hari	8 - 28 Hari
	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
Perawatan Tali pusat				
IMD				
Vitamin K1				
Imunisasi Hepatitis B				
Salep/Tetes Mata Antibiotik				
Skrining BBL/SHK				
KIA				
Tripel Eliminasi				

Bayi 0 - 1 Tahun	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
BB								
PB								
LK								
Perkembangan								
KIE								
Imunisasi								
Vit. A								
Tripel Eliminasi								

Anak 1 - 2 Tahun	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
BB								
PB								
LK								
Perkembangan								
KIE								
Imunisasi								
Vit. A, Obat Cacing								
Tripel Eliminasi								

Anak 2 - 3 Tahun	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
BB								
TB								
LK								
Perkembangan								
KIE								
Vit. A, Obat Cacing								

Anak 3 - 4 Tahun	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
BB								
TB								
LK								
Perkembangan								
KIE								
Vit. A, Obat Cacing								

Anak 4 - 5 Tahun	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
BB								
TB								
LK								
Perkembangan								
KIE								
Vit. A, Obat Cacing								

Anak 5 - 6 Tahun	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:	Tgl/Bln:
	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:	Tempat:
BB								
TB								
LK								
Perkembangan								
KIE								
Obat Cacing								

Lihat edukasi untuk bayi/anak di halaman 39-84.

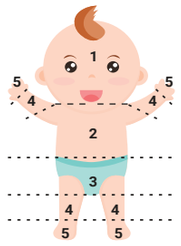
KIA 2024 Book 2.17.5 63 10/24/24 01:21

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Bayi Umur 0 - 28 Hari (Neonatus)

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Pelayanan kesehatan neonatus menggunakan pendekatan MTBS algoritma bayi muda umur < 2 bulan.

0 - 6 jam	6 - 48 jam KN1	3 - 7 hari KN2	8 - 28 hari KN3
Kondisi ---------- ---------- ---------- BB ---------- g PB ---------- cm LK ---------- cm **Inisiasi Menyusu** ☐ Dini (IMD) ☐ Vit K1 ☐ Salep/Tetes Mata ☐ Imunisasi HB Tgl/Bln/Th ---------- Jam ---------- No. Batch ----------	BB ---------- g PB ---------- cm LK ---------- cm ☐ Menyusu ☐ Tali Pusat ☐ Vit K1* ☐ Salep/Tetes Mata* ☐ Imunisasi HB* ☐ Skrining Hipotiroid Kongenital (dilakukan setelah 24 jam) ☐ Skrining Penyakit jantung bawaan kritis 24-48 jam. Hasil ---------- Tgl/Bln/Th ---------- Jam ---------- No. Batch ----------	☐ Menyusu ☐ Tali Pusat ☐ Tanda Bahaya ☐ Identifikasi Kuning ☐ Imunisasi HB* ☐ Skrining Hipotiroid Kongenital (bila belum diberikan) Tgl/Bln/Th ---------- Jam ---------- No. Batch ----------	☐ Menyusu ☐ Tali Pusat ☐ Tanda Bahaya ☐ Identifikasi Kuning ☐ Skrining Hipotiroid Kongenital s.d usia 14 hari (bila belum diberikan)  Berikan tanda pada bagian tubuh mana bayi tampak kuning dengan melingkari angka. Tgl/Bln/Th ---------- Jam ---------- No. Batch ----------
Tripel Eliminasi H ---------- S ---------- Hep B ----------	Tripel Eliminasi H ---------- S ---------- Hep B ----------	Tripel Eliminasi H ---------- S ---------- Hep B ----------	Tripel Eliminasi H ---------- S ---------- Hep B ----------
Masalah ---------- ---------- ----------	Masalah ---------- ---------- ----------	Masalah ---------- ---------- ----------	Masalah ---------- ---------- ----------
Dirujuk ke** ---------- ----------	Dirujuk ke** ---------- ----------	Dirujuk ke** ---------- ----------	Dirujuk ke** ---------- ----------
Nama Tenaga Kesehatan ---------- ---------- ----------	Nama Tenaga Kesehatan ---------- ---------- ----------	Nama Tenaga Kesehatan ---------- ---------- ----------	Nama Tenaga Kesehatan ---------- ---------- ----------

* Beri tanda – (strip) jika tidak ada masalah/tidak dirujuk.

Catatan Penting

Nama Tenaga Kesehatan

Lihat edukasi untuk bayi baru lahir di halaman 39-48.

Pelayanan Gizi (PMBA, Vit A) & Obat Cacing

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Nasihat		Bulan									
		0	1	2	3	4	5	6 - 8	9 - 11	12 - 23	23 - 59
ASI	Frekuensi menyusui										
	Posisi Menyusu (Pelekatan)										
	Asi Perah										
MPASI	Ya										
	Tidak										
Variasi MPASI	Beras/Makanan Pokok										
	Lauk/Protein										
	Minyak										
	Sayur										
	Buah										
	Lainnya										
Tekstur MPASI	Disaring										
	Dihaluskan										
	Dicincang										
	Makanan Rumah										
Jumlah setiap kali makan (di atas 6 bulan)	2 - 3 sdm (1/2 mangkok ukuran 250 ml)										
	1/2 - 3/4 mangkok (ukuran 250 ml)										
	3/4 - 1 mangkok (ukuran 250 ml)										
	1 mangkok (ukuran 250 ml)										
Frekuensi Makan	Makanan Utama (3x/hari)										
	Makanan Selingan (2x/hari)										

Vitamin A dan Obat Cacing		Bulan	Tahun				
		6 - 11	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6
VIT A KAPSUL BIRU (100.000 IU)	Februari/ Agustus						
VIT A KAPSUL MERAH (200.000 IU)	Februari						
	Agustus						
Obat Cacing							

Lihat edukasi untuk bayi/anak di halaman 39-84.

Imunisasi Dasar Bayi dan Baduta



18 Bulan

IMUNISASI
- DPT-HB-HIB 4
- Campak Rubela 2

MENCEGAH
- Difteri
- Pertusis
- Tetanus
- Hepatitis B dan Kanker Hati
- Meningitis (Radang Selaput Otak)
- Pneumonia (Radang Paru)
- Campak Rubela



12 Bulan

IMUNISASI
- PCV 3

MENCEGAH
- Pneumonia



10 Bulan

IMUNISASI
- JE **

MENCEGAH
- Japanese Encephalitis (hanya untuk daerah endemis)



9 Bulan

IMUNISASI
- Campak Rubela 1
- IPV 2 ***

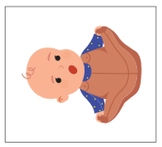
MENCEGAH
- Campak Rubela
- Polio



4 Bulan

IMUNISASI
- DPT-HB-HIB 3
- OPV 4
- IPV 1
- RV 3 *

MENCEGAH
- Difteri
- Pertusis
- Tetanus
- Hepatitis B dan Kanker Hati
- Polio
- Meningitis (Radang Selaput Otak)
- Pneumonia (Radang Paru)
- Diare



3 Bulan

IMUNISASI
- DPT-HB-HIB 2
- OPV 3
- PCV 2
- RV 2 *

MENCEGAH
- Difteri
- Pertusis
- Tetanus
- Hepatitis B dan Kanker Hati
- Polio
- Meningitis (Radang Selaput Otak)
- Pneumonia (Radang Paru)
- Diare



2 Bulan

IMUNISASI
- DPT-HB-HIB 1
- OPV 2
- PCV 1
- RV 1 *

MENCEGAH
- Difteri
- Pertusis
- Tetanus
- Hepatitis B dan Kanker Hati
- Polio
- Meningitis (Radang Selaput Otak)
- Pneumonia (Radang Paru)
- Diare



1 Bulan

IMUNISASI
- BCG
- OPV 1

MENCEGAH
- Tuber-kulosis
- Polio



0 - 24 Jam

IMUNISASI
- HB0

MENCEGAH
- Hepatitis B dan Kanker Hati

* Akar dimulai di akhir tahun 2022 di wilayah introduksi, imunisasi RV harus dilengkap sebelum usia 8 bulan.
** Di wilayah endemis.
*** Akan dimulai di akhir tahun 2022 di wilayah introduksi.

Lihat edukasi untuk bayi/anak di halaman 39-84.

Cek kaderpintar.com untuk edukasi tentang imunisasi.

Pelayanan Imunisasi

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Umur	Bulan														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	23	23 - 59
Jenis Vaksin	Tanggal Pemberian dan Paraf Petugas															
Hepatitis B (<24 Jam) No Batch:																
BCG No Batch:																
Polio tetes 1 No Batch:																
DPT-HB-Hib 1 No Batch:																
Polio Tetes 2 No Batch:																
Rotavirus (RV)1* No Batch:																
PCV 1 No Batch:																
DPT-HB-Hib 2 No Batch:																
Polio Tetes 3 No Batch:																
Rotavirus (RV)2 * No Batch:																
PCV2 No Batch:																
DPT-HB-Hib 3 No Batch:																
Polio Tetes 4 No Batch:																
Polio Suntik (IPV) 1 No Batch:																
Rotavirus (RV) 3* No Batch:																
Campak -Rubella (MR) No Batch:																
Polio Suntik (IPV) 2* No Batch:																
*Japanese Encephalitis (JE) No Batch:																
PCV3 No Batch:																
DPT-HB-Hib Lanjutan No Batch:																
Campak Rubella (MR) Lanjutan No Batch:																

* imunisasi JE baru diberikan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota percontohan

- Usia Tepat Pemberian Imunisasi
- Usia yang masih diperbolehkan untuk melengkapi Imunisasi Bayi dan Baduta (Bawah Dua Tahun)
- Usia Pemberian Imunisasi bayi dan baduta yang belum lengkap (Imunisasi Kejar)
- Usia yang tidak diperbolehkan untuk pemberian Imunisasi

Catatan Kesehatan Gigi

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Nama ---------- Umur ----------

Pemeriksaan		Jumlah Gigi		Plak		Risiko Gigi Berlubang		
Bulan	Tanggal	Ada	Berlubang	Bersih	Kotor	Tinggi	Sedang	Rendah

KIA 2024 Book 2.17.5 66 10/24/24 01:21

Lembar Pencatatan LiLA

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia	Hasil Pengukuran LiLA usia < 6 Bulan	
Bulan	Berisiko Hambatan Pertumbunan <10,0 cm	Pertumbuhan Baik ≥ 11,0 cm
1		
2		
3		
4		
5		

Tulis hasil pengukuran LiLA atau berikan tanda x pada kotak yang sesuai.

Usia	Hasil Pengukuran LiLA usia > 6 Bulan		
Bulan	Gizi Buruk <11,5 cm	Gizi Kurang 11,5 - 12,4 cm	Gizi Baik ≥ 12,5 cm
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

Lihat edukasi untuk pengukuran LiLA di halaman 49.

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Catatan Pelayanan Kesehatan Anak

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Tabel Pertumbuhan Anak 0-2 Tahun

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Umur	LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
	Berat Badan (Kg)		Panjang Badan (cm)		Berat Badan (Kg)		Panjang Badan (cm)	
Bulan	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual
0	2,5 - 3,9		46,1 - 51,8		2,4 - 3,7		45,4 - 51,0	
1	3,4 - 5,1		50,8 - 56,7		3,2 - 4,8		49,8 - 55,6	
2	4,3 - 6,3		54,4 - 60,4		3,9 - 5,8		53,0 - 59,1	
3	5,0 - 7,2		57,3 - 63,5		4,5 - 6,6		55,6 - 61,9	
4	5,6 - 7,8		59,7 - 66,0		5,0 - 7,3		57,8 - 64,3	
5	6,0 - 8,4		61,7 - 68,0		5,4 - 7,8		59,6 - 66,2	
6	6,4 - 8,8		63,3 - 69,8		5,7 - 8,2		61,2 - 68,0	
7	6,7 - 9,2		64,8 - 71,3		6,0 - 8,6		62,7 - 69,6	
8	6,9 - 9,6		66,2 - 72,8		6,3 - 9,0		64,0 - 71,1	
9	7,1 - 9,9		67,5 - 74,2		6,5 - 9,3		65,3 - 72,6	
10	7,4 - 10,2		68,7 - 75,6		6,7 - 9,6		66,5 - 73,9	
11	7,6 - 10,5		69,9 - 76,9		6,9 - 9,9		67,7 - 75,3	
12	7,7 - 10,8		71,0 - 78,1		7,0 - 10,1		68,9 - 76,6	
13	7,9 - 11,0		72,1 - 79,3		7,2 - 10,4		70,0 - 77,8	
14	8,1 - 11,3		73,1 - 80,5		7,4 - 10,6		71,0 - 79,1	
15	8,3 - 11,5		74,1 - 81,7		7,6 - 10,9		72,0 - 80,2	
16	8,4 - 11,7		75,0 - 82,8		7,7 - 11,1		73,0 - 81,4	
17	8,6 - 12,0		76,0 - 83,9		7,9 - 11,4		74,0 - 82,5	
18	8,8 - 12,2		76,9 - 85,0		8,1 - 11,6		74,9 - 83,6	
19	8,9 - 12,5		77,7 - 86,0		8,2 - 11,8		75,8 - 84,7	
20	9,1 - 12,7		78,6 - 87,0		8,4 - 12,1		76,7 - 85,7	
21	9,2 - 12,9		79,4 - 88,0		8,6 - 12,3		77,5 - 86,7	
22	9,4 - 13,2		80,2 - 89,0		8,7 - 12,5		78,4 - 87,7	
23	9,5 - 13,4		81,0 - 89,9		8,9 - 12,8		79,2 - 88,7	
24	9,7 - 13,6		81,7 - 90,9		9,0 - 13,0		80,0 - 89,6	

Keterangan: Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang.

KMS LAKI-LAKI

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

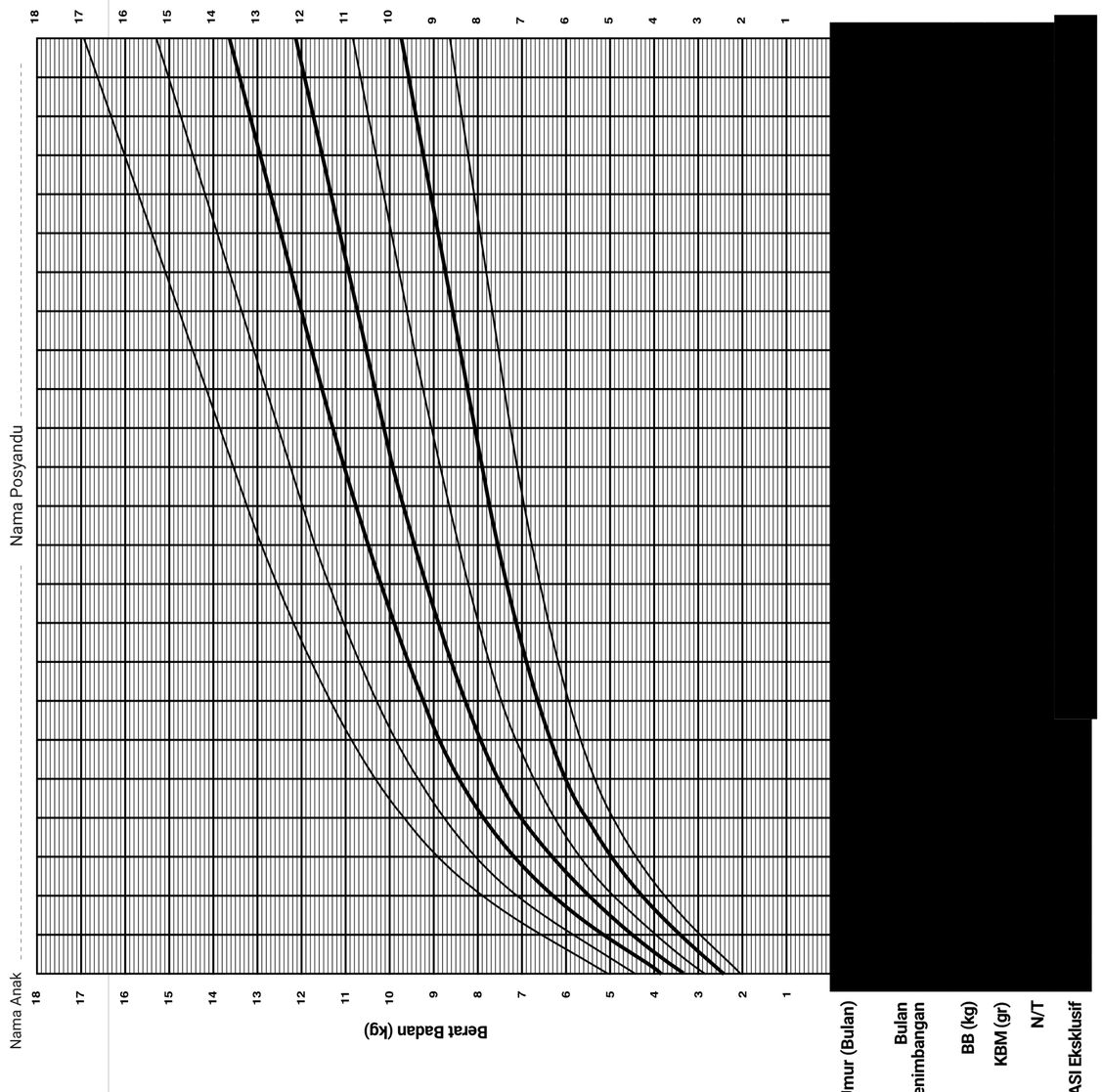
Kartu Menuju Sehat untuk Laki-Laki 0 - 2 Tahun

Timbanglah anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai.
KBM digunakan bila ada keraguan menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan.

Rujuk bila berat badan anak tidak naik (T) atau di bawah garis merah atau di atas garis orange.

Nama Anak

Nama Posyandu



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
Naik (N)	Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB paling sedikit) atau lebih
Tidak Naik (T)	Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan BB kurang dari KBM.

Petugas kesehatan memastikan plotting hasil penimbangan dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Kader kesehatan melalukan plotting hasil penimbangan, KIE kepada ibu dan rujukan ke petugas kesehatan.

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

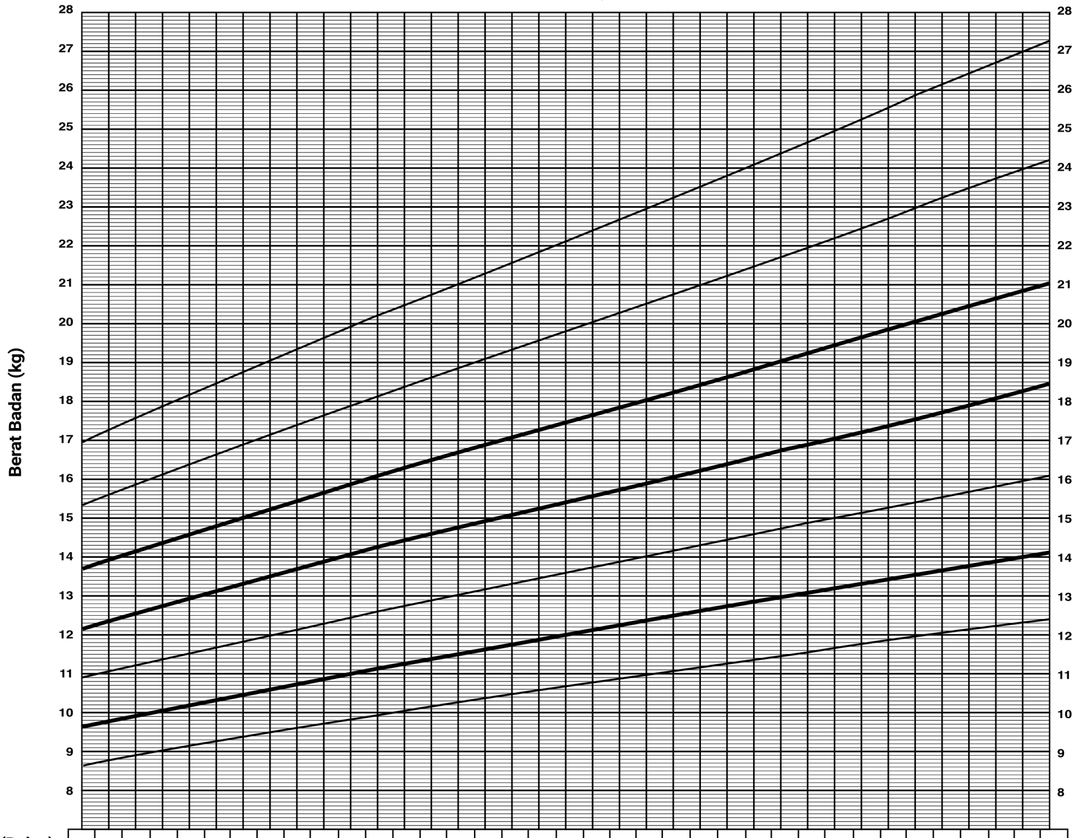
Kartu Menuju Sehat untuk Laki-Laki 2 - 5 Tahun

KMS KARTU MENUJU SEHAT LAKI-LAKI

Timbanglah anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai.
KBM digunakan bila ada keraguan menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan.

Rujuk bila berat badan anak tidak naik (T) atau di bawah garis merah atau di atas garis orange.

Nama Anak ..... Nama Posyandu .....



Umur (Bulan)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Bulan Penimbangan																																					
BB (kg)																																					
KBM (gr)	200																																				
N/T																																					

Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
Naik (N)	Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB paling sedikit) atau lebih
Tidak Naik (T)	Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan BB kurang dari KBM.

Kader kesehatan melalukan ploting hasil penimbangan, KIE kepada ibu dan rujukan ke petugas kesehatan.

Petugas kesehatan memastikan ploting hasil penimbangan dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Laki-Laki 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Berat Badan sangat kurang (*severely underweight*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Berat badan kurang (*underweight*)
-2 SD sampai dengan +1 SD	Berat badan normal
>+1 SD	Risiko berat badan lebih

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - LAKI-LAKI

KIA 2024 Book 2.17.5 68

10/24/24 01:21

KIA 2024 Book 2.17.5 69

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Laki-Laki 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Berat Badan sangat kurang (*severely underweight*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Berat badan kurang (*underweight*)
-2 SD sampai dengan +1 SD	Berat badan normal
>+1 SD	Risiko berat badan lebih

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

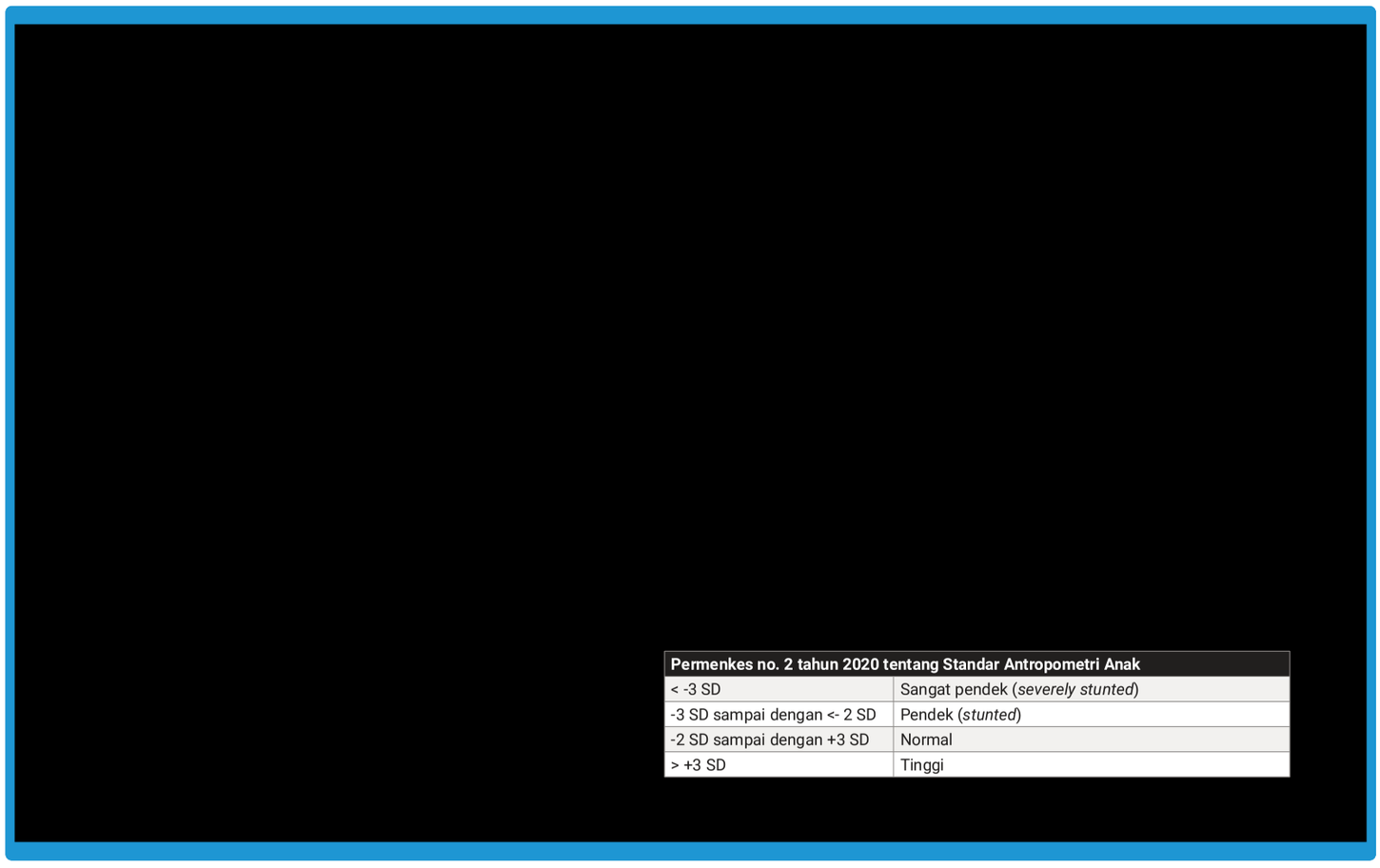
Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - LAKI-LAKI

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Panjang Badan Menurut Umur Anak Laki-Laki 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Sangat pendek (*severely stunted*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Pendek (*stunted*)
-2 SD sampai dengan +3 SD	Normal
> +3 SD	Tinggi

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

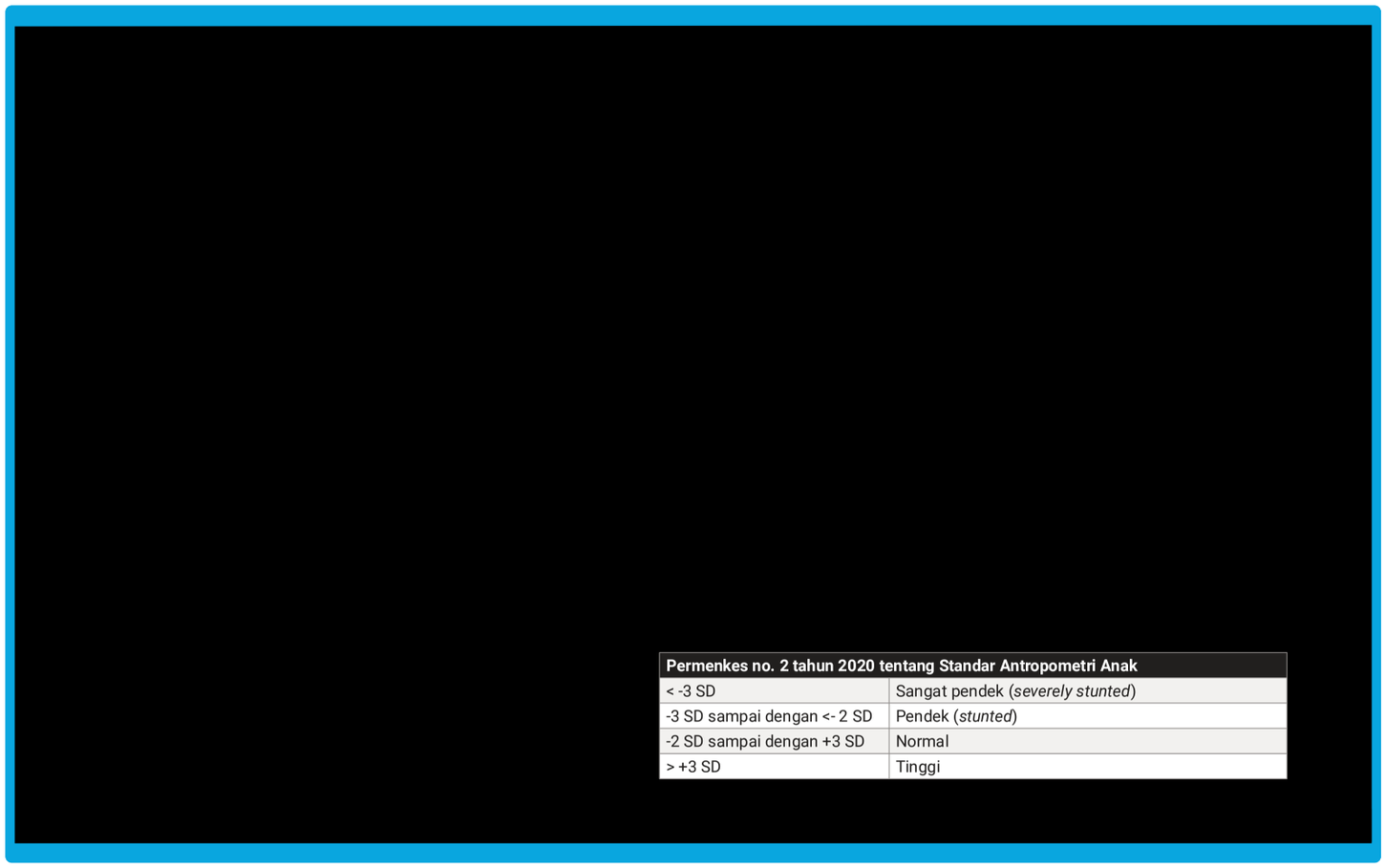
10/24/24 01:21

KIA 2024 Book 2.17.5 70

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Tinggi Badan Menurut Umur Anak Laki-Laki 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Sangat pendek (*severely stunted*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Pendek (*stunted*)
-2 SD sampai dengan +3 SD	Normal
> +3 SD	Tinggi

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

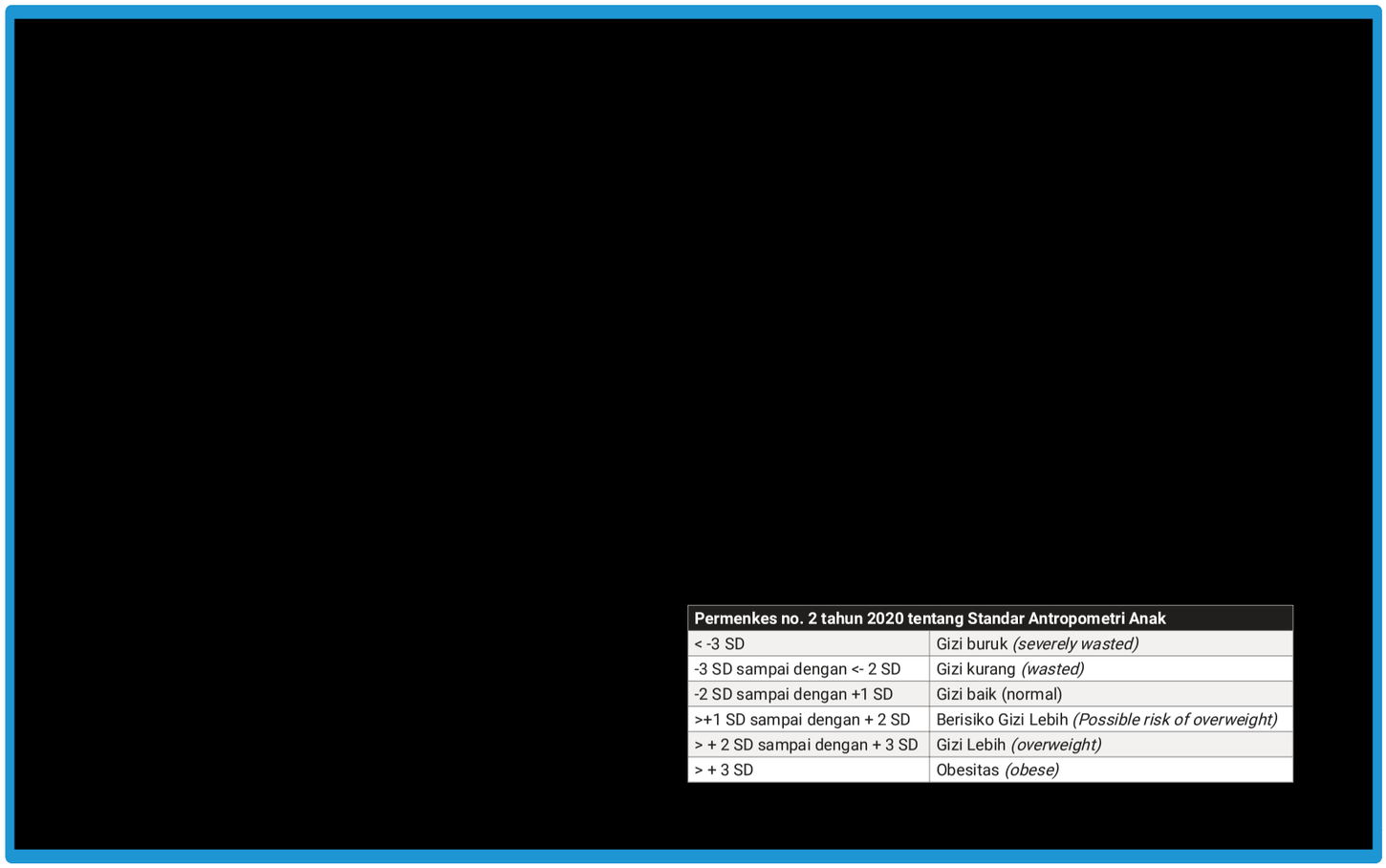
PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - LAKI-LAKI

10/24/24 01:21

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Panjang Badan Anak Laki-Laki 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

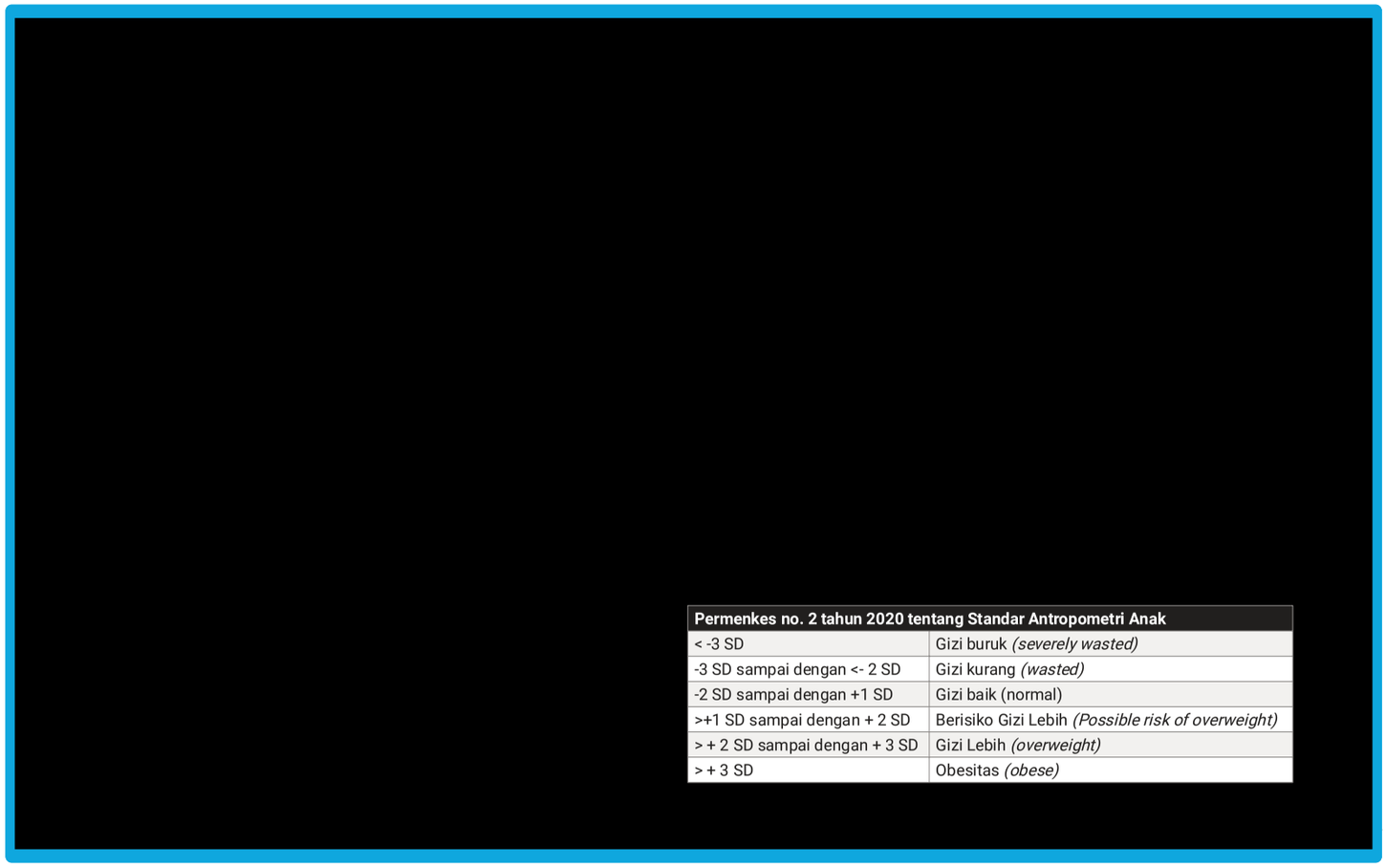
Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak Laki-Laki 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

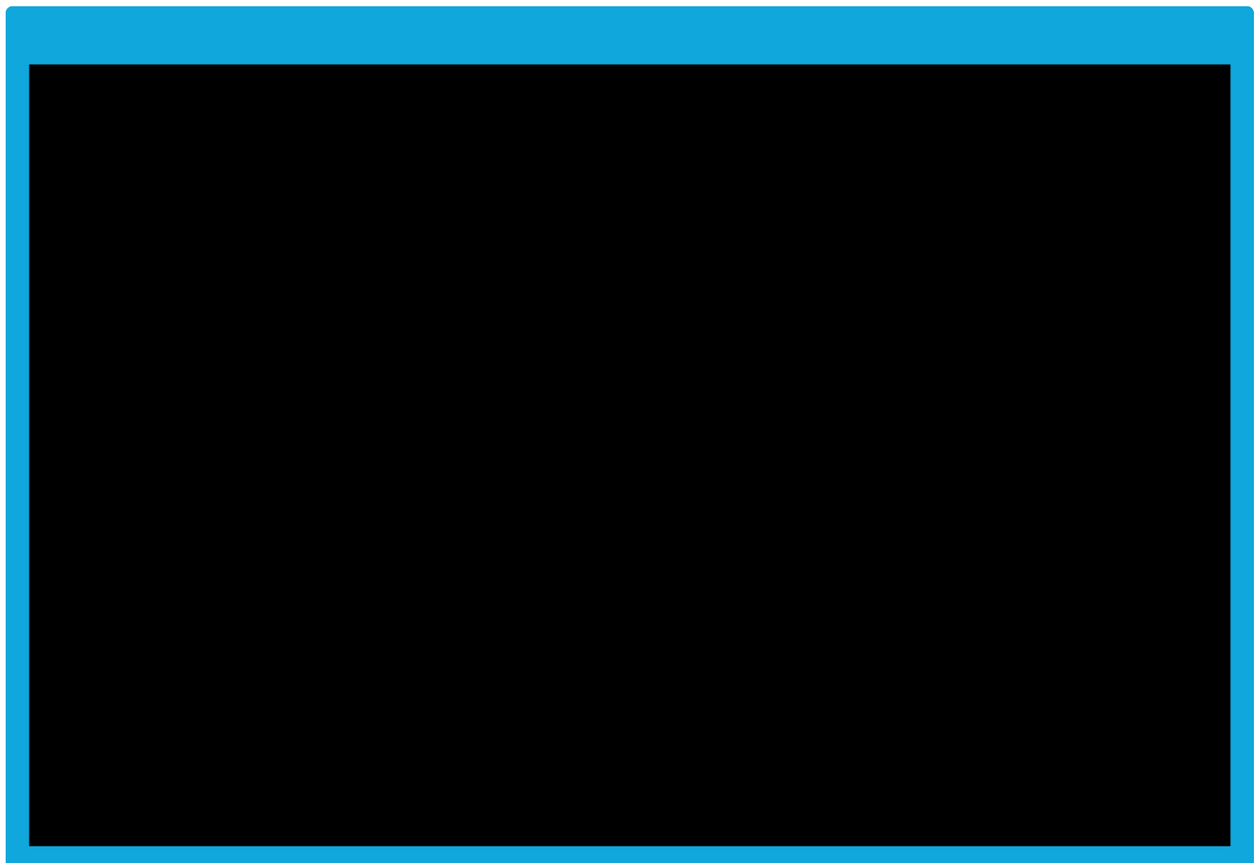
Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Indeks Massa Tubuh Menurut Umur Anak Laki-Laki 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Indeks Massa Tubuh Menurut Umur Anak Laki-Laki 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Lingkar Kepala Anak Laki-Laki 0 -5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
>+ 2 SD	Makrosefali
-2 SD sampai dengan +2 SD	Normal
< -2 SD	Mikrosefali

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

KIA 2024 Book 2.17.5 73 10/24/24 01:21

Catatan Pemeriksaan Anak

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Status tumbuh kembang anak pada saat pemeriksaan, sesuai hasil ploting pada lembar kurva pertumbuhan dan hasil pelayanan SDIDTK dan MTBS.

KMS
KARTU MENUJU SEHAT PEREMPUAN

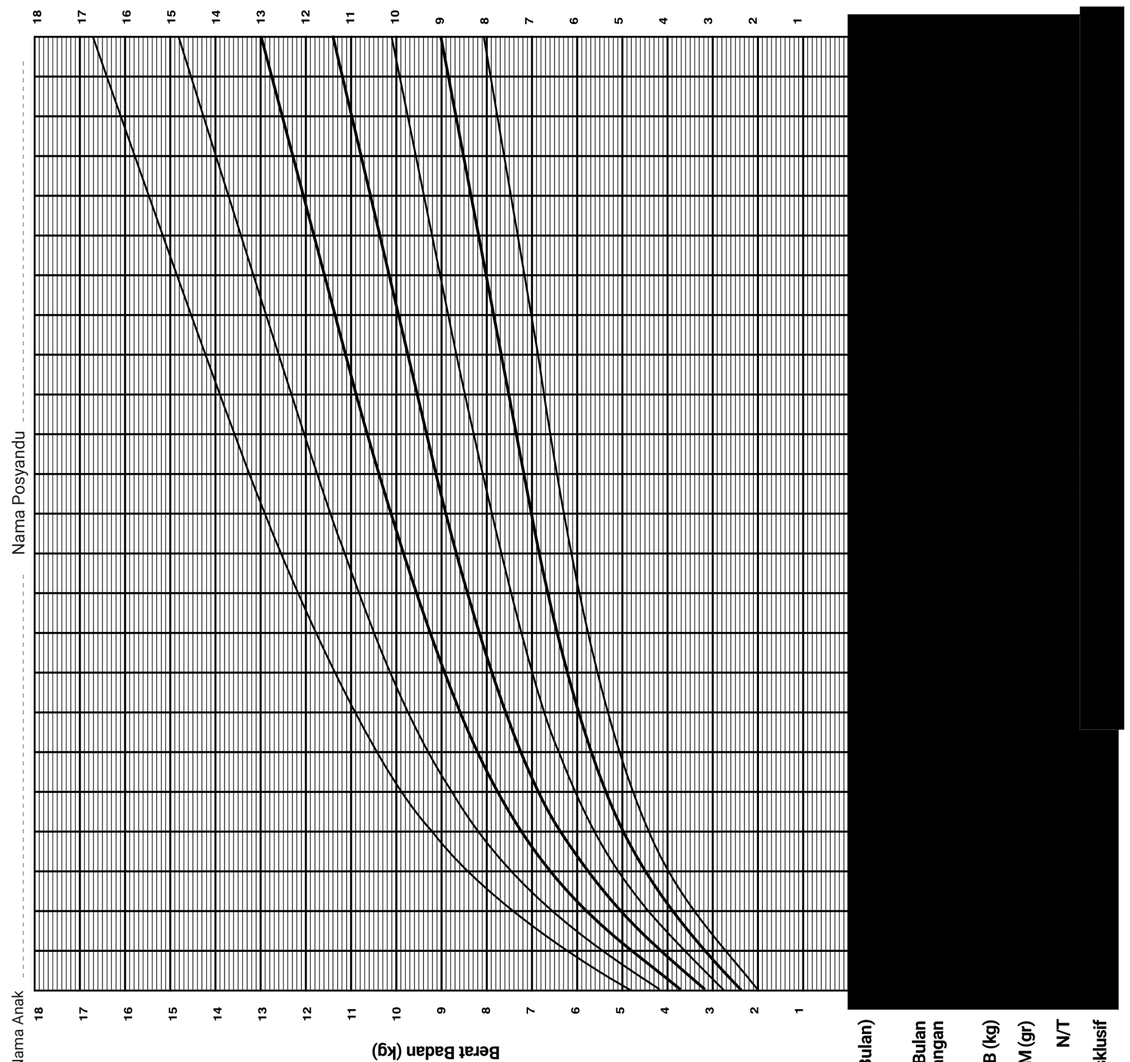
Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Kartu Menuju Sehat untuk Perempuan 0 - 2 Tahun

Timbanglah anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai.
KBM digunakan bila ada keraguan menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan.

① Rujuk bila berat badan anak tidak naik (T) atau di bawah garis merah atau di atas garis orange.

Nama Anak ..... Nama Posyandu .....



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
Naik (N)	Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB paling sedikit) atau lebih
Tidak Naik (T)	Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan BB kurang dari KBM.

Kader kesehatan melakukan ploting hasil penimbangan, KIE kepada ibu dan rujukan ke petugas kesehatan.

Petugas kesehatan memastikan ploting hasil penimbangan dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

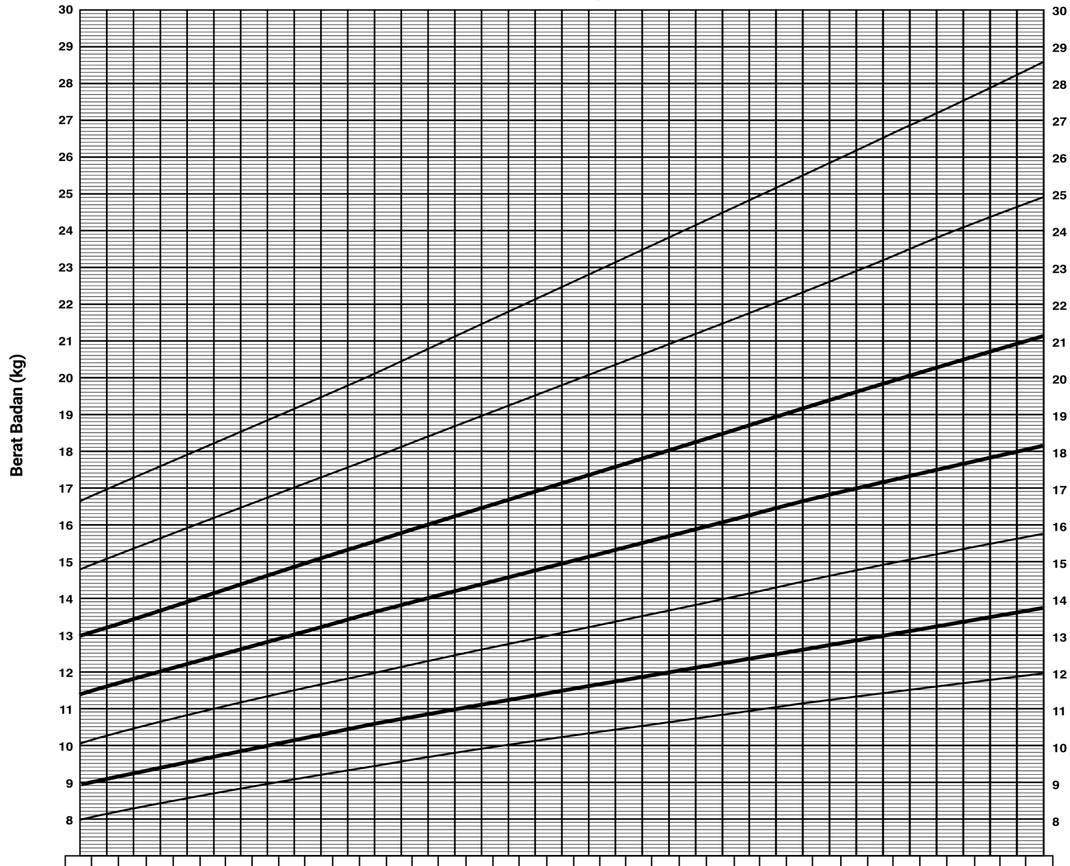
Kartu Menuju Sehat untuk Perempuan 2 - 5 Tahun

KMS KARTU MENUJU SEHAT PEREMPUAN

Timbanglah anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai.
KBM digunakan bila ada keraguan menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan.

Rujuk bila berat badan anak tidak naik (T) atau di bawah garis merah atau di atas garis orange.

Nama Anak ..... Nama Posyandu .....



Umur (Bulan)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Bulan Penimbangan																																					
BB (kg)																																					
KBM (gr)	200																																				
N/T																																					

Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
Naik (N)	Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB paling sedikit) atau lebih
Tidak Naik (T)	Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan BB kurang dari KBM.

Kader kesehatan melalukan ploting hasil penimbangan, KIE kepada ibu dan rujukan ke petugas kesehatan.

Petugas kesehatan memastikan ploting hasil penimbangan dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Perempuan 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Berat Badan sangat kurang (*severely underweight*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Berat badan kurang (*underweight*)
-2 SD sampai dengan +1 SD	Berat badan normal
>+1 SD	Risiko berat badan lebih

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - PEREMPUAN

KIA 2024 Book 2.17.5 74
10/24/24 01:21

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Perempuan 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Berat Badan sangat kurang (*severely underweight*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Berat badan kurang (*underweight*)
-2 SD sampai dengan +1 SD	Berat badan normal
>+1 SD	Risiko berat badan lebih

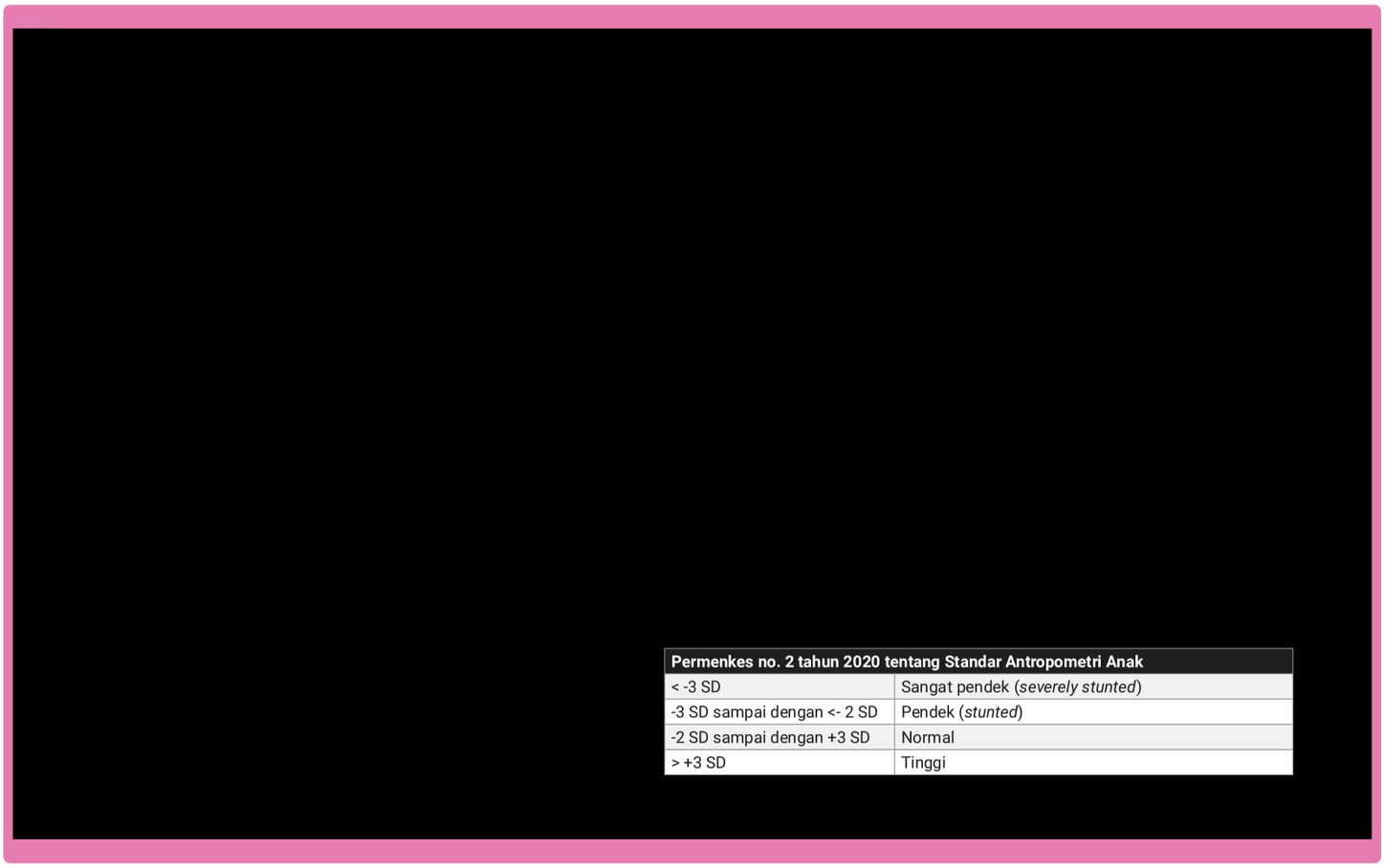
Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Panjang Badan Menurut Umur Anak Perempuan 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Sangat pendek (*severely stunted*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Pendek (*stunted*)
-2 SD sampai dengan +3 SD	Normal
> +3 SD	Tinggi

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - PEREMPUAN

KIA 2024 Book 2.17.5 76

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Tinggi Badan Menurut Umur Anak Perempuan 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Sangat pendek (*severely stunted*)
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Pendek (*stunted*)
-2 SD sampai dengan +3 SD	Normal
> +3 SD	Tinggi

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Panjang Badan Anak Perempuan 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - PEREMPUAN

10/24/24 01:21

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak Perempuan 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Indeks Massa Tubuh Menurut Umur Anak Perempuan 0 - 2 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Indeks Massa Tubuh Menurut Umur Anak Perempuan 2 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Lingkar Kepala Anak Perempuan 0 - 5 Tahun

World Health Organization



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
>+ 2 SD	Makrosefali
-2 SD sampai dengan +2 SD	Normal
< -2 SD	Mikrosefali

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN - PEREMPUAN

World Health Organization



Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

Grafik Indeks Massa Tubuh Menurut Umur 5 - 6 Tahun



Permenkes no. 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	
< -3 SD	Gizi buruk *(severely wasted)*
-3 SD sampai dengan <- 2 SD	Gizi kurang *(wasted)*
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi baik (normal)
>+1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko Gizi Lebih *(Possible risk of overweight)*
> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi Lebih *(overweight)*
> + 3 SD	Obesitas *(obese)*

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Nomor-Nomor Telepon Penting

119	110	NOMOR LAINNYA
Ambulans	Polisi	
113	117	NOMOR LAINNYA
Pemadam Kebakaran	Bencana	

Kumpulan Link Penting

Website Ayo Sehat
https://ayosehat.kemkes.go.id

Chatbot Edukasi Ayo Sehat
https://wa.me/6281277889912?text=ayosehat

Konseling Menyusui
https://telekonseling-pmba-kemenkes.com

Kumpulan Resep MPASI
https://link.kemkes.go.id/ResepMPASI2

Kumpulan Link Penting untuk Kesehatan Mental
https://link.kemkes.go.id/KesehatanMentalKeluarga

Kumpulan Link Penting untuk Anak Disabilitas
https://link.kemkes.go.id/InfoAnakDisabilitas

Hubungi Kemenkes untuk Pertanyaan, Pengaduan & Saran
https://www.kemkes.go.id/id/layanan/kontak-kami